



Fundamentos y planeación de la estrategia entorno hogar saludable

Breve descripción:

Este componente aborda los fundamentos y la planeación de la estrategia de entorno hogar saludable, incluyendo conceptos clave, análisis del territorio, determinantes sociales, enfoque territorial e intersectorial y formulación de intervenciones. Permite al aprendiz comprender y estructurar acciones orientadas a la promoción de la salud en el entorno familiar.

Tabla de contenido

Introducción	4
1. Fundamentos de la estrategia	8
1.1. Conceptos básicos	10
1.2. Objetivos de la estrategia	15
1.3. Características de la estrategia.....	19
1.4. Población sujeto y escenarios	22
2. Marco conceptual y operativo	25
2.1. Marco conceptual.....	26
2.2. Marco operativo	31
2.3. Metodología de implementación.....	36
2.4. Herramientas de intervención	38
3. Enfoque territorial e intersectorial.....	40
3.1. Principios.....	43
3.2. Actores del territorio	46
4. Determinantes sociales en el entorno hogar	50
4.1. Clasificación de determinantes	52
4.2. Condiciones del entorno hogar.....	55
4.3. Factores de riesgo y protección	57

5. Intervenciones en el entorno hogar.....	60
5.1. Planeación territorial	62
5.2. Identificación de necesidades	65
5.3. Intervenciones poblacionales y colectivas	68
5.4. Procesos de salud pública	71
6. Promoción de la salud y plan de acción	74
6.1. Promoción de la salud	76
6.2. Herramientas de caracterización	79
6.3. Herramientas educativas	82
6.4. Formulación del plan de acción	86
Síntesis	91
Glosario	92
Referencias bibliográficas	94
Créditos	95

Introducción

La estrategia de entorno hogar saludable orienta la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad en el marco de la Atención Primaria en Salud (APS). Este enfoque reconoce el hogar como un escenario estratégico de intervención, en el cual convergen condiciones sociales, económicas, culturales y ambientales que inciden directamente en la situación de salud de las familias y comunidades.

Este componente formativo desarrolla los fundamentos conceptuales y operativos necesarios para comprender las dinámicas del entorno familiar, los determinantes sociales de la salud y los procesos de articulación intersectorial en el territorio. A partir de estos elementos, se orienta la implementación de acciones en salud pública con un enfoque integral, que responde a las necesidades identificadas en los contextos locales.

En coherencia con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS, 2012), la estrategia de entornos saludables se orienta al fortalecimiento de las capacidades de las familias y los territorios, mediante intervenciones que promueven prácticas saludables y favorecen entornos protectores. Estas acciones se desarrollan considerando las particularidades del contexto, lo que permite una respuesta pertinente frente a los factores que afectan la salud en el entorno hogar.

A lo largo de este proceso formativo, el aprendiz desarrolla capacidades para el análisis del territorio, la identificación de necesidades en salud y la formulación de planes de acción, en articulación con los procesos de la salud pública. De esta manera, se contribuye a la planeación de intervenciones pertinentes, basadas en evidencia y

alineadas con las políticas públicas, favoreciendo un enfoque territorial, diferencial e intersectorial.

Para comprender la importancia del contenido y los temas abordados, se recomienda acceder al siguiente video:

Video 1. Fundamentos y planeación de la estrategia de entorno hogar saludable.



[Enlace de reproducción del video](#)

Transcripción del video. Fundamentos y planeación de la estrategia de entorno hogar saludable.

¡ En Colombia, numerosas familias viven en condiciones que afectan su salud sin saberlo: una vivienda sin ventilación, el agua almacenada sin tapar o el desconocimiento de los servicios de salud disponibles. Esas condiciones no son problemas médicos, son determinantes sociales que se resuelven con presencia en el territorio, educación en salud y acciones organizadas con las familias y la comunidad.

Transcripción del video. Fundamentos y planeación de la estrategia de entorno hogar saludable.

Este espacio de aprendizaje desarrolla los fundamentos conceptuales y operativos necesarios para comprender la estrategia de entorno hogar saludable. Se estudian sus objetivos, sus características, las familias y comunidades a quienes se dirige la estrategia y los escenarios de intervención, así como el marco conceptual y operativo que sustenta su aplicación en el territorio, en coherencia con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social.

La salud de las familias no depende solo del médico. Depende también de la vivienda, la escuela, el barrio y las redes de apoyo comunitario. Por eso, el componente estudia el enfoque territorial e intersectorial y los determinantes sociales del entorno hogar: las condiciones materiales, las dinámicas familiares, los hábitos de vida y la cohesión social como factores que protegen o amenazan el bienestar de cada familia.

Con ese diagnóstico, el componente avanza hacia la planeación de las intervenciones: identificar y priorizar necesidades, desarrollar acciones educativas y colectivas con la comunidad y aplicar herramientas de caracterización en cada hogar. Todo culmina en la formulación del plan de acción, el instrumento sencillo y verificable que convierte lo aprendido en compromisos reales con cada familia colombiana.

De esta manera, se promueve el desarrollo de competencias para intervenir en salud pública con enfoque territorial, pensamiento analítico y compromiso con las familias y comunidades colombianas, fortaleciendo la capacidad de planear acciones

Transcripción del video. Fundamentos y planeación de la estrategia de entorno hogar saludable.

que transformen de manera real y sostenible las condiciones de vida en el entorno hogar.

1. Fundamentos de la estrategia

El estudio de los fundamentos de la estrategia constituye el punto de partida del proceso formativo, pues proporciona el lenguaje común que permite interpretar las situaciones de salud presentes en los hogares. Esta base conceptual orienta el análisis posterior del territorio, de los determinantes sociales y de las intervenciones que se desarrollan con las familias.

En el contexto laboral del talento humano que apoya la promoción y prevención en salud, estos fundamentos se aplican en actividades cotidianas como las visitas domiciliarias, la caracterización de los hogares y la orientación de las familias. Su comprensión facilita identificar con precisión los elementos que configuran un entorno protector o de riesgo.

La estrategia de entorno hogar saludable se configura como una intervención en salud pública orientada al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias, mediante acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en el contexto donde transcurre la vida cotidiana. Este enfoque reconoce el hogar como un escenario fundamental para la generación de prácticas saludables y la reducción de factores de riesgo que afectan la salud individual y colectiva.

Desde esta perspectiva, la comprensión del entorno hogar implica reconocer la interacción entre factores físicos, sociales y comportamentales que inciden en la salud de las familias. Estos elementos permiten identificar condiciones que pueden favorecer el bienestar o generar riesgos en la vida cotidiana.

Entre los aspectos más relevantes se encuentran:

- **Condiciones de la vivienda:** corresponden a las características físicas del lugar donde habita la familia, como ventilación, iluminación, acceso a agua potable, saneamiento básico, seguridad y distribución de los espacios. Por ejemplo, una vivienda con buena ventilación y manejo adecuado de residuos disminuye el riesgo de enfermedades respiratorias, infecciones y accidentes en el hogar.
- **Dinámicas familiares:** hacen referencia a las formas de convivencia, comunicación, cuidado y apoyo entre los integrantes del hogar. Estas relaciones pueden fortalecer la salud emocional y física cuando promueven el respeto, la corresponsabilidad y el acompañamiento. Por ejemplo, una familia que organiza turnos para el cuidado de una persona mayor favorece su bienestar y reduce la sobrecarga de un solo cuidador.
- **Hábitos cotidianos:** son las prácticas que se realizan diariamente y que influyen en la salud individual y familiar, como la alimentación, la higiene, la actividad física, el descanso y el uso responsable de los servicios de salud. Por ejemplo, lavarse las manos antes de preparar alimentos y mantener limpios los utensilios de cocina ayuda a prevenir enfermedades gastrointestinales.

Estos aspectos constituyen factores determinantes en la configuración de entornos protectores o de riesgo para la población. Su reconocimiento facilita el análisis integral del hogar y orienta la planeación de acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y fortalecimiento de prácticas de autocuidado en las familias.

En coherencia con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS, 2012), esta estrategia se orienta al fortalecimiento de las capacidades de las

familias para gestionar su salud, promoviendo prácticas saludables y favoreciendo entornos que contribuyan al bienestar. Su implementación requiere una comprensión integral del contexto en el que viven las personas, así como de los factores que influyen en una situación de salud.

A partir de estos elementos, resulta necesario abordar los conceptos básicos que sustentan la estrategia, los cuales permiten comprender de manera clara los componentes del entorno hogar y su relación con la salud.

1.1. Conceptos básicos

La comprensión de la estrategia de entorno hogar saludable requiere reconocer los conceptos que explican la relación entre las personas, el lugar donde habitan y las condiciones que influyen en su bienestar. Estos conceptos permiten analizar el hogar como un escenario de vida cotidiana, donde se expresan prácticas de cuidado, formas de convivencia, condiciones materiales y factores del territorio.

En salud pública, esta base conceptual permite identificar necesidades, riesgos y factores protectores en las familias. Su análisis ayuda a comprender que el bienestar no depende únicamente de la atención médica, sino también de las condiciones de habitabilidad, las relaciones familiares, los hábitos cotidianos y el acceso a recursos básicos en cada contexto.

En el territorio colombiano, esta mirada resulta fundamental porque las familias viven en escenarios diversos, con condiciones sociales, culturales, ambientales y económicas particulares. Estas diferencias permiten comprender que las acciones de

promoción y prevención deben adaptarse a las necesidades de cada contexto, como ocurre en las siguientes zonas:

- **Zonas rurales:** territorios con población dispersa, actividades agropecuarias y acceso variable a servicios básicos e institucionales.
- **Zonas urbanas:** espacios con mayor concentración poblacional, oferta de servicios, movilidad constante y diversos riesgos ambientales o sociales.
- **Zonas ribereñas:** comunidades ubicadas cerca de ríos, expuestas a inundaciones, contaminación del agua y dificultades de acceso.

Por esta razón, el análisis del entorno hogar debe considerar las particularidades sociales, culturales, ambientales y económicas de cada comunidad, con el fin de orientar acciones pertinentes de promoción y prevención.

La lectura integrada de estos conceptos permite comprender que el entorno hogar saludable no depende de un solo elemento, sino de la relación entre condiciones materiales, prácticas de cuidado y dinámicas cotidianas. Esta mirada facilita analizar por qué una misma situación puede representar un factor protector en una familia y un riesgo en otra, según el contexto territorial, social y cultural en el que se encuentre.

Desde esta perspectiva, el análisis del entorno hogar permite reconocer situaciones que requieren acompañamiento familiar, comunitario o institucional. Estas situaciones orientan la identificación de riesgos y la planeación de acciones pertinentes en cada territorio:

- **Manejo inadecuado de residuos:** se presenta cuando las basuras no se separan, almacenan o disponen de manera segura, lo que puede atraer vectores y generar malos olores o contaminación. Por ejemplo, en una vivienda rural, dejar residuos

orgánicos cerca de la cocina puede favorecer la presencia de moscas y afectar la inocuidad de los alimentos.

- **Falta de ventilación:** ocurre cuando los espacios del hogar no permiten la circulación adecuada del aire, especialmente en habitaciones, cocinas o zonas donde se usan fogones. Por ejemplo, una vivienda con ventanas cerradas y humo acumulado puede aumentar molestias respiratorias en niñas, niños, personas mayores o integrantes con enfermedades previas.
- **Dificultades de acceso al agua segura:** se relacionan con la falta de agua potable, almacenamiento inadecuado o consumo de agua sin tratamiento. Por ejemplo, en una comunidad dispersa, usar agua de quebrada sin hervir, filtrar o clorar puede aumentar el riesgo de enfermedades gastrointestinales en los integrantes de la familia.
- **Sobrecarga del cuidado:** aparece cuando una sola persona asume la mayoría de las responsabilidades familiares, como atender niños, personas mayores, personas enfermas o tareas domésticas. Por ejemplo, una madre cuidadora sin apoyo familiar puede presentar cansancio físico, estrés y menor tiempo para asistir a controles o participar en actividades comunitarias.
- **Ausencia de redes de apoyo:** se presenta cuando la familia no cuenta con acompañamiento de vecinos, líderes comunitarios, instituciones o servicios cercanos para resolver necesidades cotidianas. Por ejemplo, una familia recién llegada a un barrio puede tener dificultades para conocer rutas de atención, jornadas de vacunación o espacios de orientación comunitaria.

El reconocimiento de estas situaciones permite comprender mejor las condiciones que influyen en el bienestar familiar. Además, facilita la planeación de acciones educativas, preventivas y comunitarias orientadas a fortalecer prácticas de cuidado, reducir riesgos y promover entornos protectores en el hogar.

Comprender los conceptos básicos del entorno hogar saludable permite reconocer las condiciones que influyen en el bienestar familiar y orientar intervenciones pertinentes en cada territorio (MSPS, 2012).

Para facilitar la comprensión de estos conceptos y su relación con la estrategia, se presenta a continuación una síntesis comparativa:

Tabla 1. Conceptos básicos del entorno hogar saludable

Concepto	Definición	Elementos clave	Relación con la salud
Hogar	Espacio social donde interactúan personas que comparten vínculos y dinámicas de convivencia.	Relaciones familiares, prácticas cotidianas, convivencia.	Influye en hábitos, comportamientos y prácticas de cuidado.
Vivienda	Entorno físico donde habitan las personas y que debe garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad.	Infraestructura, servicios públicos, saneamiento, seguridad.	Determina exposición a riesgos ambientales y sanitarios.
Familia	Núcleo social donde se establecen relaciones de cuidado y se configuran estilos de vida.	Roles, relaciones, apoyo, dinámicas familiares.	Puede actuar como factor protector o de riesgo.

Concepto	Definición	Elementos clave	Relación con la salud
Entorno de hogar saludable	Espacio donde las condiciones físicas, sociales y comportamentales favorecen la salud.	Prácticas saludables, condiciones adecuadas, entorno protector.	Promueve bienestar y previene enfermedades.

La comprensión integrada de estos conceptos permite interpretar el entorno hogar como un sistema dinámico en el que convergen múltiples factores que influyen en la salud. Este análisis facilita la identificación de situaciones que requieren intervención, así como la formulación de acciones orientadas a la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.

Por ejemplo, una familia que vive en una vivienda con poca ventilación, manejo inadecuado de residuos y limitado acceso a agua segura puede estar expuesta a enfermedades respiratorias, gastrointestinales o transmitidas por vectores. Sin embargo, si esa misma familia fortalece prácticas de higiene, organiza el cuidado de sus integrantes y participa en acciones comunitarias, puede reducir riesgos y mejorar sus condiciones de bienestar.

De esta manera, los conceptos básicos sirven como punto de partida para analizar las condiciones del entorno hogar y orientar intervenciones pertinentes. Su comprensión favorece la planeación de acciones educativas, familiares y comunitarias, acordes con las necesidades identificadas en cada territorio y con los propósitos de la salud pública.

A partir de esta comprensión, se hace necesario profundizar en los objetivos y características de la estrategia, los cuales orientan la forma en que se desarrollan las intervenciones en el entorno.

1.2. Objetivos de la estrategia

En el marco de la estrategia de entorno hogar saludable, los objetivos orientan la planificación y ejecución de acciones dirigidas al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias, a partir de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad en el contexto del hogar. Estos objetivos permiten estructurar las intervenciones de manera coherente con las necesidades del territorio y con los lineamientos de la salud pública.

De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS, 2012), la estrategia se enfoca en fortalecer las capacidades de las familias y comunidades para gestionar su salud, mediante la identificación de factores de riesgo y la potenciación de factores protectores en el entorno hogar. Este enfoque favorece el desarrollo de prácticas saludables y la construcción de entornos que contribuyen al bienestar integral.

En este sentido, los objetivos permiten pasar del análisis del entorno a la formulación de acciones concretas. Para lograrlo, se deben considerar las condiciones:

- a) Habitabilidad:** condiciones físicas adecuadas para vivir con seguridad.
- b) Dinámicas familiares:** relaciones, roles y prácticas de convivencia cotidiana.
- c) Factores de riesgo:** situaciones que pueden afectar el bienestar familiar.

- d) Capacidades comunitarias:** recursos sociales disponibles para apoyar a las familias.
- e) Articulación institucional:** coordinación entre entidades para responder a necesidades.
- f) Actores sociales y familias:** participación conjunta en acciones de cuidado territorial.

Estas condiciones permiten orientar los objetivos de la estrategia de manera integral y contextualizada. Su reconocimiento facilita la planeación de acciones pertinentes, acordes con las necesidades del entorno hogar y la realidad de cada territorio.

Para comprender mejor el alcance de la estrategia, se presentan los principales objetivos que orientan su implementación. Cada uno permite reconocer una línea de acción necesaria para fortalecer el bienestar familiar, organizar la intervención en el territorio y promover entornos protectores desde una perspectiva integral:

- **Analizar las condiciones del entorno hogar**

Permite reconocer las características físicas, sociales y familiares que influyen en el bienestar de las personas. Este análisis considera aspectos como vivienda, acceso a servicios básicos, prácticas de higiene, relaciones familiares y riesgos del territorio. Por ejemplo, en una comunidad rural, identificar viviendas con humedad, falta de ventilación o almacenamiento inadecuado de agua permite priorizar acciones educativas y preventivas ajustadas a la realidad local.

- **Fortalecer capacidades familiares para el autocuidado**

Busca que las familias reconozcan prácticas cotidianas que favorecen su bienestar y reduzcan situaciones de riesgo en el hogar. Incluye acciones relacionadas con higiene, alimentación, actividad física, cuidado de personas mayores, atención a niñas y niños y uso adecuado de los servicios disponibles. Por ejemplo, una familia que aprende a tratar el agua antes de consumirla puede prevenir enfermedades gastrointestinales y mejorar sus prácticas de cuidado diario.

- **Promover el acceso y uso adecuado de los servicios**

Orienta a las familias para que conozcan las rutas de atención, programas, jornadas y servicios disponibles en su territorio. Este objetivo facilita que las personas acudan oportunamente a controles, vacunación, orientación familiar o atención preventiva. Por ejemplo, una familia informada sobre las jornadas de vacunación puede completar los esquemas de niñas y niños, reduciendo riesgos evitables y fortaleciendo la protección familiar.

- **Formular planes de acción según el contexto territorial**

Permite organizar actividades, responsables, recursos y tiempos de acuerdo con las necesidades identificadas en cada comunidad. Este objetivo evita aplicar acciones generales sin considerar las particularidades del territorio. Por ejemplo, en una zona ribereña, el plan puede priorizar el manejo seguro del agua, la prevención de enfermedades transmitidas por vectores y la preparación familiar ante temporadas de lluvia o inundación.

- **Gestionar acciones intersectoriales en el territorio**

Promueve la coordinación entre salud, educación, ambiente, servicios públicos, líderes comunitarios e instituciones locales para responder a problemas que no dependen de un solo sector. Por ejemplo, si una comunidad presenta acumulación de residuos, la intervención puede requerir educación familiar, apoyo de la entidad territorial, jornadas de limpieza y articulación con servicios de recolección.

- **Realizar seguimiento y evaluación de las intervenciones**

Permite verificar si las acciones implementadas responden a las necesidades identificadas y generan cambios en las prácticas familiares. Este proceso ayuda a reconocer avances, dificultades y oportunidades de mejora. Por ejemplo, después de una jornada educativa sobre lavado de manos, el seguimiento permite observar si la familia dispone de agua, jabón y rutinas adecuadas para mantener la práctica.

La comprensión de estos objetivos permite orientar la intervención en el entorno hogar de manera ordenada, pertinente y contextualizada. Además, facilita que las acciones no se limiten a actividades aisladas, sino que respondan a necesidades reales, fortalezcan capacidades familiares y promuevan cambios sostenibles en la vida cotidiana.

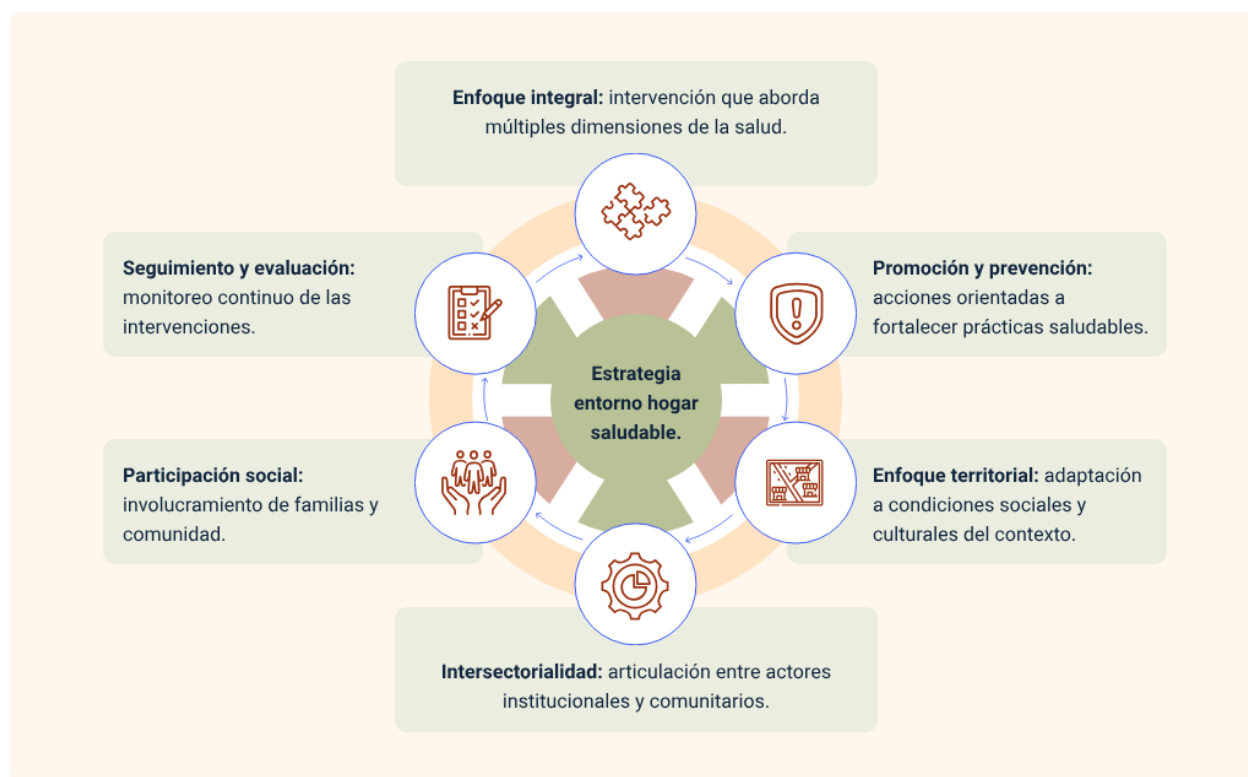
A partir de estos objetivos, resulta necesario reconocer las características de la estrategia, porque estas explican la forma en que deben desarrollarse las acciones en el territorio. Su análisis permite comprender por qué la intervención debe ser integral, participativa, intersectorial, territorial y centrada en las condiciones reales de las familias.

1.3. Características de la estrategia

La estrategia de entorno hogar saludable se sustenta en un enfoque integral que reconoce la interacción de múltiples factores que inciden en la salud de las familias. Su implementación se orienta a la generación de respuestas articuladas en el territorio, que permitan abordar de manera conjunta las condiciones sociales, ambientales y familiares que influyen en el bienestar.

En este marco, las acciones en salud no se desarrollan de manera aislada, sino que integran diferentes componentes que se complementan entre sí. La promoción de la salud y la prevención de la enfermedad se articulan con el análisis del contexto territorial, la participación de la comunidad y la coordinación entre actores, lo que favorece intervenciones más pertinentes y sostenibles.

Figura 1. Elementos de la estrategia entorno hogar saludable



El esquema presentado evidencia cómo estos elementos se relacionan y se fortalecen mutuamente en el desarrollo de la estrategia. La integración de estos componentes permite que las acciones en el entorno hogar respondan no solo a la identificación de riesgos, sino también al fortalecimiento de capacidades familiares y comunitarias para el cuidado de la salud.

En este sentido, la implementación de la estrategia implica reconocer que las condiciones del entorno influyen directamente en el bienestar de las familias. Por ello, se requiere una intervención continua que articule los siguientes componentes:

- **Procesos educativos**

Fortalecen los conocimientos, actitudes y prácticas de cuidado en las familias mediante orientaciones claras, contextualizadas y aplicables en la vida diaria. Estos procesos permiten comprender los riesgos presentes en el hogar, reconocer hábitos protectores y tomar decisiones informadas para mejorar las condiciones del entorno. También favorecen la participación de niñas, niños, personas mayores y cuidadores en acciones sencillas de prevención.

Ejemplo: una charla familiar sobre lavado de manos ayuda a prevenir enfermedades y mejorar hábitos cotidianos.

- **Acompañamiento familiar**

Permite reconocer las necesidades del hogar, orientar decisiones y promover cambios progresivos en las prácticas de cuidado. Este proceso se basa en el diálogo, la observación del entorno y la identificación conjunta de factores protectores o situaciones de riesgo. Además, facilita que las familias participen en la definición de

compromisos posibles, de acuerdo con sus condiciones sociales, culturales y territoriales.

Ejemplo: una visita domiciliaria puede ayudar a reconocer riesgos, acordar compromisos y fortalecer prácticas de autocuidado.

- **Articulación institucional**

Facilita la coordinación entre entidades, comunidad y actores territoriales para responder de manera integral a las necesidades identificadas en el entorno hogar. Esta articulación permite unir recursos, conocimientos y responsabilidades de diferentes sectores, como salud, educación, ambiente, servicios públicos y organizaciones comunitarias. Su propósito es evitar acciones aisladas y promover respuestas más pertinentes, sostenibles y acordes con la realidad local.

Ejemplo: una acción conjunta entre salud, ambiente y líderes comunitarios puede mejorar el manejo de residuos.

La integración de estos componentes permite avanzar hacia la construcción de entornos protectores, en los que las familias participan de manera activa en el mejoramiento de sus condiciones de vida y en el fortalecimiento del cuidado cotidiano.

A partir de esta comprensión, resulta necesario identificar a quiénes se dirige la estrategia y en qué escenarios se desarrolla. Este análisis permite reconocer la diversidad de familias, comunidades y territorios que participan en las acciones orientadas al fortalecimiento del entorno hogar saludable.

1.4. Población sujeto y escenarios

La estrategia de entorno hogar saludable se dirige a las familias y comunidades que habitan en el territorio, reconociendo la diversidad de condiciones sociales, económicas y culturales que influyen en su situación de salud. En este contexto, la población sujeta no se limita a individuos con enfermedad, sino que incluye a personas sanas, grupos familiares y comunidades, en coherencia con el enfoque de la Atención Primaria en Salud.

Desde esta perspectiva, se priorizan aquellos grupos que presentan mayor exposición a factores de riesgo o condiciones de vulnerabilidad, los cuales requieren intervenciones diferenciadas que respondan a sus necesidades específicas. Este enfoque permite orientar acciones en salud de manera equitativa, favoreciendo la reducción de brechas y el mejoramiento de las condiciones de vida.

En coherencia con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS, 2012), la identificación de la población sujeta se realiza mediante procesos de caracterización territorial, que permiten reconocer las condiciones del entorno, las dinámicas familiares y los factores que inciden en la salud.

En este contexto, se destacan grupos poblacionales que requieren especial atención en el entorno hogar:

- Niños, niñas y adolescentes.
- Mujeres gestantes y en periodo de lactancia.
- Personas mayores.
- Personas con enfermedades crónicas.
- Población en condición de vulnerabilidad social o económica.

La identificación de estos grupos permite orientar las intervenciones hacia el fortalecimiento de capacidades, la promoción de prácticas saludables y la reducción de riesgos en el entorno hogar, en coherencia con las necesidades del territorio.

En continuidad con lo anterior, es necesario reconocer los escenarios en los cuales se desarrollan estas intervenciones, los cuales amplían el alcance de la estrategia más allá del espacio físico de la vivienda. En coherencia con el enfoque territorial, la estrategia de entorno hogar saludable se desarrolla en diversos escenarios que permiten abordar la salud desde una perspectiva integral, reconociendo la interacción entre el entorno familiar y el contexto social.

En este sentido, la intervención se extiende hacia diferentes escenarios del entorno social, donde se articulan actores, recursos y acciones para fortalecer el bienestar de las familias. Esta organización permite reconocer que el cuidado no depende solo del hogar, sino también de la comunidad, las instituciones y las redes de apoyo presentes en el territorio:

- **La comunidad**

Agrupar a familias, vecinos y líderes que participan en acciones de cuidado, prevención y apoyo colectivo.

- **Instituciones educativas**

Promueven hábitos saludables, prevención de riesgos y formación para el cuidado desde el entorno escolar.

- **Servicios de salud**

Orientan acciones de promoción, prevención, atención y seguimiento según las necesidades de la población.

- **Espacios comunitarios y redes sociales**

Facilitan la participación, el encuentro y la coordinación de apoyos entre familias, organizaciones y comunidad.

La articulación de estos escenarios amplía el alcance de las intervenciones y favorece respuestas más integrales en el territorio. Su integración permite conectar necesidades familiares, recursos institucionales y capacidades comunitarias para mejorar las condiciones de bienestar.

La comprensión de los escenarios de intervención permite reconocer que la estrategia requiere una base conceptual y operativa clara para orientar su aplicación en el territorio. Por ello, el marco conceptual y operativo organiza los referentes, enfoques y herramientas que facilitan la planeación de acciones pertinentes, articuladas con las necesidades de las familias y las comunidades.

2. Marco conceptual y operativo

Una vez comprendidos los fundamentos de la estrategia de entorno hogar saludable, resulta necesario profundizar en los elementos que orientan su desarrollo en el territorio. El marco conceptual y operativo permite organizar los referentes, enfoques, procesos y herramientas que sustentan la planeación de intervenciones en salud pública, de acuerdo con las necesidades de las familias y las comunidades.

Para comprender su función dentro de la estrategia, es importante diferenciar los elementos que integran este marco. Cada uno cumple un papel específico en la interpretación del contexto, la definición de acciones y el seguimiento de las intervenciones en el entorno hogar:

- **Marco conceptual:** reúne los referentes teóricos que permiten comprender la estrategia desde una perspectiva integral, territorial y familiar.
- **Marco operativo:** define la forma en que los fundamentos conceptuales se traducen en acciones organizadas en el territorio.
- **Determinantes sociales:** explican cómo las condiciones sociales, económicas, ambientales y culturales influyen en el bienestar de la población.
- **Dinámicas familiares:** permiten reconocer prácticas de cuidado, convivencia, apoyo y organización dentro del hogar.
- **Intervenciones en salud pública:** corresponden a acciones planificadas para promover el bienestar, prevenir riesgos y fortalecer capacidades familiares.
- **Seguimiento de acciones:** permite verificar avances, dificultades y resultados durante la implementación de la estrategia.

Estos elementos orientan la aplicación de la estrategia y facilitan una intervención coherente con las realidades del territorio. Su comprensión permite pasar del análisis de las condiciones familiares y comunitarias a la organización de acciones pertinentes, articuladas y sostenibles.

Desde una mirada pedagógica, el marco conceptual y operativo ayuda a comprender la estrategia mediante acciones clave que guían su aplicación:

- Reconocer los fundamentos que explican la estrategia.
- Analizar las condiciones del entorno hogar.
- Identificar necesidades, riesgos y factores protectores.
- Planear intervenciones según el contexto territorial.
- Articular actores institucionales, comunitarios y familiares.
- Realizar seguimiento a las acciones implementadas.

A partir de este marco, se abordan los elementos que orientan la comprensión y aplicación de la estrategia. En primer lugar, se profundiza en el marco conceptual; posteriormente, se desarrolla el marco operativo, la metodología de implementación y las herramientas de intervención en el entorno hogar.

2.1. Marco conceptual

El marco conceptual de la estrategia de entorno hogar saludable establece los fundamentos teóricos que orientan la comprensión de la salud desde una perspectiva integral, reconociendo la interacción entre factores individuales, familiares, sociales y ambientales. Este enfoque permite analizar la situación de salud de la población más

allá de la presencia de enfermedad, incorporando elementos relacionados con las condiciones de vida y los contextos en los que se desarrollan las personas.

Desde esta perspectiva, la Atención Primaria en Salud (APS) se constituye en el eje orientador de la estrategia, al promover intervenciones centradas en la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la participación activa de la comunidad. Este enfoque reconoce que la salud se construye en los entornos cotidianos, siendo el hogar un escenario clave para la implementación de acciones que favorezcan el bienestar.

Reconocer cada uno de estos factores en la vida real de las familias colombianas es el primer paso para orientar la intervención con precisión. A continuación, se describe lo que implica cada uno en el trabajo de promoción y prevención en salud:

- **Condiciones de vivienda**

Una casa sin ventilación, con humedad o hacinamiento incrementa el riesgo de enfermedades respiratorias e infecciosas. Identificar estas condiciones durante la visita domiciliaria permite actuar sobre causas concretas y no solo sobre síntomas.

- **Acceso a servicios básicos**

La ausencia de agua potable, alcantarillado o recolección de residuos es un riesgo sanitario directo. Cuando el equipo detecta esta carencia, la canalización hacia la entidad territorial competente hace parte de la intervención en salud.

- **Dinámicas familiares**

La calidad de las relaciones al interior del hogar determina si la familia funciona como red protectora o como fuente de tensión. Esta dimensión se explora en la caracterización y orienta las acciones de acompañamiento familiar.

- **Hábitos de vida**

Las prácticas cotidianas de higiene, alimentación y actividad física son modificables mediante educación para la salud. La estrategia no se limita a registrarlos; diseña acciones que promuevan cambios sostenibles en el hogar.

Estos cuatro factores se refuerzan mutuamente y configuran el nivel real de vulnerabilidad o protección de cada hogar. Analizarlos de forma articulada permite diseñar intervenciones que respondan a la complejidad de la vida de las familias colombianas.

De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS, 2012), la estrategia de entornos saludables se fundamenta en un enfoque que integra la promoción de la salud, la gestión del riesgo y la acción intersectorial, lo que permite abordar las problemáticas de manera integral y articulada en el territorio.

En este sentido, el marco conceptual se estructura a partir de un conjunto de elementos que orientan la comprensión y aplicación de la estrategia en el entorno hogar:

Tabla 2. Elementos del marco conceptual de la estrategia entorno hogar saludable

Elemento	Descripción	Aplicación en el entorno hogar
Atención Primaria en Salud (APS).	Estrategia que orienta la atención integral en salud con énfasis en promoción, prevención y participación comunitaria.	Permite desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención de riesgos en el hogar.
Determinantes sociales de la salud.	Condiciones sociales, económicas, culturales y ambientales que influyen en la salud.	Facilita el análisis de factores de riesgo y protección en el entorno familiar.
Promoción de la salud.	Proceso que permite a las personas mejorar el control sobre su salud.	Orienta el desarrollo de prácticas saludables en la vida cotidiana.
Prevención de la enfermedad.	Acciones orientadas a evitar la aparición de enfermedades o reducir su impacto.	Permite intervenir factores de riesgo presentes en el entorno hogar.
Enfoque territorial.	Reconocimiento de las particularidades del contexto social y geográfico.	Facilita la adaptación de las intervenciones a las condiciones del territorio.

Elemento	Descripción	Aplicación en el entorno hogar
Intersectorialidad.	Articulación entre diferentes sectores para abordar problemas de salud.	Permite integrar acciones con actores institucionales y comunitarios.
Participación social.	Involucramiento de la comunidad en la toma de decisiones en salud.	Fortalece el rol de las familias en el cuidado de la salud.

La integración de estos elementos permite comprender la estrategia de entorno hogar saludable como una intervención en salud pública que articula diferentes enfoques para abordar de manera integral las condiciones que afectan la salud en el hogar. Esta visión facilita la formulación de acciones orientadas al mejoramiento de la calidad de vida, considerando tanto los factores de riesgo como las capacidades de las familias y comunidades.

La salud no se construye solo en los consultorios: se construye en la casa, en el barrio, en la forma en que las familias comen, se relacionan y cuidan su entorno. Por eso, la estrategia de entorno hogar saludable lleva la acción hasta donde vive la gente. (MSPS, 2012)

En el contexto territorial, el análisis de los determinantes sociales en un hogar permite identificar condiciones concretas y orientar acciones específicas para cada una:

- **Hacinamiento en la vivienda:** se orienta la gestión ante la entidad territorial para mejorar las condiciones habitacionales y se desarrollan actividades educativas sobre uso adecuado de los espacios del hogar.
- **Limitaciones en el acceso a servicios básicos:** se activa la articulación institucional con los sectores competentes, como los de agua potable, saneamiento básico y recolección de residuos, para garantizar condiciones mínimas de salubridad en el hogar.
- **Prácticas inadecuadas de autocuidado:** se diseñan e implementan acciones de educación para la salud dirigidas a la familia, orientadas a fortalecer hábitos de higiene, alimentación y cuidado personal sostenibles.

Este análisis integrado, condición identificada y acción orientada, es el que convierte la visita domiciliaria en una intervención en salud con impacto real sobre la vida de las familias colombianas.

En coherencia con lo anterior, el marco conceptual orienta la forma en que se interpretan las condiciones del entorno y se definen las acciones en salud, lo cual da paso al desarrollo del marco operativo, donde estos fundamentos se traducen en procesos concretos para la intervención en el territorio.

2.2. Marco operativo

El marco operativo de la estrategia de entorno hogar saludable establece los procesos mediante los cuales los fundamentos conceptuales se traducen en acciones concretas en el territorio. Este componente orienta la organización, ejecución y seguimiento de las intervenciones en salud pública, garantizando coherencia entre el

análisis de las condiciones del entorno y la implementación de acciones dirigidas a las familias.

Este enfoque sistemático se traduce en cuatro momentos articulados que orientan la intervención en el entorno hogar. Cada uno cumple una función específica dentro del proceso:

a) Identificación de necesidades

Proceso mediante el cual el equipo de salud reconoce, a partir de la observación directa y la información recolectada en la visita domiciliaria, las condiciones que afectan la salud de la familia. Por ejemplo, en una vivienda de un barrio de invasión en el Tolima, la identificación puede revelar simultáneamente hacinamiento, agua sin tratamiento y un adulto mayor sin valoración médica reciente.

b) Priorización de problemáticas

Selección de las situaciones que requieren atención urgente, según su impacto en la salud, la población afectada y la posibilidad real de intervención. Por ejemplo, ante varias necesidades identificadas en un mismo hogar, el equipo prioriza primero la canalización del adulto mayor al servicio de salud, porque representa el riesgo más inmediato para la vida.

c) Formulación de acciones

Definición de las intervenciones específicas que responden a cada problemática priorizada, con responsables, recursos y tiempos establecidos. Por ejemplo, tras priorizar el riesgo hídrico en una vereda, el equipo formula acciones educativas sobre

tratamiento casero del agua y gestiona simultáneamente el reporte ante la secretaría de salud municipal para su atención estructural.

d) Articulación con actores del territorio

Coordinación con las instituciones, organizaciones y líderes comunitarios presentes en el territorio para sumar capacidades en la respuesta a las necesidades identificadas. Por ejemplo, cuando una familia requiere mejoramiento de vivienda, el equipo articula con la alcaldía, la junta de acción comunal y la EPS para definir qué le corresponde a cada actor dentro de la solución.

La articulación de estos cuatro momentos garantiza que ninguna necesidad identificada en el hogar quede sin una respuesta organizada, verificable y conectada con los recursos del territorio.

Desde esta perspectiva, la operación de la estrategia implica el desarrollo de procesos organizados que facilitan la toma de decisiones en salud, sustentadas en información del contexto y en el reconocimiento de los determinantes sociales que afectan a la población. De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS, 2012), la implementación de acciones en el territorio requiere la articulación de componentes técnicos, sociales y comunitarios que permitan una intervención integral.

En este marco, la estrategia se desarrolla mediante una secuencia de procesos que orientan su aplicación en el entorno hogar:

Tabla 3. Procesos del marco operativo de la estrategia entorno hogar saludable

Proceso	Descripción	Aplicación en el entorno hogar
Caracterización del entorno.	Identificación de condiciones sociales, económicas, ambientales y familiares.	Permite reconocer necesidades, riesgos y factores protectores en el hogar.
Análisis y priorización.	Evaluación de problemáticas identificadas según su impacto en la salud.	Facilita la toma de decisiones sobre las intervenciones a desarrollar.
Planeación de intervenciones.	Definición de acciones orientadas a la promoción de la salud y prevención de riesgos.	Permite estructurar planes de acción acordes al contexto territorial.
Implementación de acciones.	Desarrollo de actividades educativas, preventivas y de acompañamiento.	Contribuye al fortalecimiento de prácticas saludables en las familias.
Seguimiento y evaluación.	Monitoreo de las acciones implementadas y sus resultados.	Permite ajustar las intervenciones y mejorar su efectividad.

La articulación de estos procesos permite que la estrategia se desarrolle de manera organizada y continua, evitando intervenciones aisladas y favoreciendo la sostenibilidad de las acciones en el tiempo. Este enfoque facilita la adaptación de las intervenciones a las condiciones específicas del territorio, garantizando mayor pertinencia y efectividad.

En el contexto territorial, la aplicación del marco operativo permite transformar los hallazgos de la visita domiciliaria en acciones concretas:

- **Hacinamiento y deficiencias en servicios básicos:** identificados en el hogar, orientan la priorización de intervenciones de saneamiento y mejoramiento de las condiciones habitacionales.
- **La priorización:** define las acciones de educación en salud dirigidas a la familia según las necesidades más urgentes del hogar.
- **La articulación institucional:** conecta los hallazgos del equipo con los actores competentes para dar respuesta a las necesidades que superan la capacidad de intervención directa.
- **Las acciones formuladas:** responden de manera directa a las necesidades identificadas, lo que evidencia la aplicación real del marco operativo en situaciones concretas del territorio colombiano.

La articulación de estos hallazgos con las acciones correspondientes demuestra que el marco operativo no es un esquema teórico, es una guía de trabajo que organiza cada decisión del equipo de salud en el país.

El marco operativo convierte el diagnóstico en acción: identificar, priorizar, formular y articular son los cuatro pasos que transforman una visita domiciliaria en una intervención organizada con impacto real en la salud de las familias.

Conocer los procesos del marco operativo no es suficiente si no se sabe cómo ponerlos en marcha. La metodología de implementación responde precisamente a esa

pregunta, ya que proporciona las orientaciones prácticas que permiten desarrollar cada proceso en el contexto real de las familias colombianas, adaptando la estrategia a las condiciones particulares de cada territorio, sin perder la coherencia con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social.

2.3. Metodología de implementación

La metodología de implementación de la estrategia de entorno hogar saludable corresponde al conjunto de orientaciones que permiten desarrollar las intervenciones en el territorio de manera organizada, articulada y coherente con las condiciones del contexto. Este proceso integra los fundamentos conceptuales y operativos, facilitando su aplicación en escenarios reales.

En este sentido, la implementación de la estrategia no responde a un modelo rígido, sino a un proceso dinámico que se adapta a las características del territorio, las condiciones de las familias y los recursos disponibles. Este enfoque permite desarrollar acciones pertinentes, orientadas al mejoramiento de las condiciones de vida en el entorno hogar.

De acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS, 2012), la implementación de la estrategia se orienta por un proceso secuencial que articula el análisis del contexto, la identificación de necesidades y el desarrollo de acciones en salud pública.

La secuencia que orienta la implementación de la estrategia en cada territorio se organiza en cinco fases articuladas entre sí. Reconocerlas permite comprender el orden

lógico del trabajo con las familias y la función específica que cumple cada momento dentro del proceso:

- Identificación de necesidades.
- Planeación de acciones.
- Implementación.
- Seguimiento.
- Evaluación.

La articulación de estas fases permite estructurar la intervención de manera lógica y progresiva, garantizando que las acciones desarrolladas respondan a las necesidades identificadas en el territorio. Este proceso favorece la continuidad de las intervenciones y la adaptación de las estrategias según las condiciones del entorno.

En la práctica, la articulación de las cinco fases se evidencia en situaciones concretas del territorio colombiano:

- **Identificación de necesidades:** el equipo recorre la comunidad y reconoce las condiciones del entorno, como hacinamiento, falta de agua potable o prácticas inadecuadas de higiene.
- **Planeación de acciones:** con base en las necesidades priorizadas, se definen actividades educativas y de acompañamiento pertinentes para cada familia.
- **Implementación:** se desarrollan las actividades acordadas en el hogar, con participación activa de los integrantes de la familia.
- **Seguimiento:** el equipo verifica el cumplimiento de los compromisos y el avance en las condiciones del hogar.

- **Evaluación:** se valoran los resultados obtenidos y se ajustan las acciones según las condiciones del territorio.

Esta secuencia demuestra que la metodología no es un esquema teórico, es una guía práctica que ordena cada decisión del equipo de salud desde el primer contacto con la familia hasta la verificación de los cambios logrados.

Saber cómo implementar la estrategia lleva a una pregunta natural: ¿con qué recursos concretos se desarrolla cada fase en el hogar? Las herramientas de intervención responden a esa pregunta: son los instrumentos técnicos que hacen posible pasar del análisis del entorno a la acción organizada con las familias colombianas.

2.4. Herramientas de intervención

La implementación de la estrategia de entorno hogar saludable se apoya en el uso de herramientas que facilitan el análisis del contexto, la planificación de acciones y la orientación de intervenciones en el territorio. Estas herramientas permiten organizar la información, apoyar la toma de decisiones y garantizar coherencia entre las necesidades identificadas y las acciones formuladas.

En el marco de la Atención Primaria en Salud, las herramientas de intervención no se limitan a instrumentos operativos, sino que constituyen recursos técnicos que orientan el desarrollo de procesos en salud pública, desde la caracterización del entorno hasta la formulación de planes de acción.

Desde esta perspectiva, las herramientas pueden clasificarse según su función dentro del proceso de intervención:

- **Herramientas de caracterización:** orientadas a la recolección y organización de información sobre las condiciones del entorno hogar, permitiendo identificar necesidades, factores de riesgo y condiciones de vulnerabilidad.
- **Herramientas de análisis:** utilizadas para interpretar la información recolectada, facilitando la priorización de problemáticas y la toma de decisiones en el territorio.
- **Herramientas de planificación:** permiten estructurar las acciones a desarrollar, definiendo objetivos, actividades, responsables y recursos en función de las necesidades identificadas.
- **Herramientas educativas:** orientadas a la promoción de la salud y al fortalecimiento de capacidades en las familias, mediante procesos pedagógicos adaptados al contexto.

Estas herramientas se articulan entre sí y cumplen un papel fundamental en la estructuración de las intervenciones, ya que permiten pasar del análisis del entorno a la formulación de acciones concretas.

En coherencia con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, su uso debe responder a las características del territorio, garantizando pertinencia, claridad en la información y coherencia con los procesos de salud pública.

De esta manera, las herramientas de intervención constituyen un soporte técnico para la planeación de acciones en el entorno hogar. Su aplicación cobra mayor sentido cuando se comprende el enfoque territorial e intersectorial, que permite reconocer las condiciones propias de cada territorio y los actores con quienes se articula la respuesta en salud para las familias colombianas.

3. Enfoque territorial e intersectorial

El enfoque territorial e intersectorial constituye un elemento fundamental en la implementación de la estrategia de entorno hogar saludable, al permitir comprender la salud como un proceso influenciado por múltiples factores que trascienden el ámbito individual y requieren una respuesta articulada en el territorio. Este enfoque orienta las intervenciones hacia el reconocimiento de las particularidades sociales, culturales, económicas y ambientales que caracterizan a cada comunidad.

El enfoque territorial implica analizar el contexto en el que habitan las familias, considerando las condiciones del entorno, las dinámicas comunitarias y la disponibilidad de recursos institucionales. Este análisis permite adaptar las acciones en salud a las necesidades reales de la población, favoreciendo intervenciones pertinentes y contextualizadas que contribuyan al mejoramiento de la situación de salud.

El enfoque intersectorial reconoce que la salud no depende exclusivamente del sector sanitario, sino que está determinada por la interacción de diversos sectores como educación, vivienda, ambiente y desarrollo social. En este sentido, la articulación entre actores institucionales y comunitarios se convierte en un elemento clave para abordar de manera integral los determinantes sociales de la salud.

En coherencia con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS, 2016), el enfoque territorial e intersectorial promueve la coordinación de acciones entre diferentes sectores y niveles de gobierno, con el fin de optimizar recursos, evitar duplicidad de esfuerzos y fortalecer la respuesta frente a las problemáticas identificadas en el entorno hogar.

En el territorio colombiano, la articulación entre sectores permite dar respuestas concretas a problemáticas que ninguna entidad puede resolver de manera aislada. Los siguientes ejemplos ilustran cómo opera este enfoque en situaciones reales:

- **Condiciones inadecuadas de vivienda**

Cuando las visitas domiciliarias evidencian techos en mal estado, pisos de tierra o paredes húmedas en un barrio de invasión, el equipo de salud articula con la oficina de vivienda municipal o con el programa de mejoramiento habitacional del Ministerio de Vivienda para gestionar la intervención estructural que protege la salud de la familia.

- **Limitaciones en el acceso a servicios básicos**

Ante la ausencia de agua potable o alcantarillado en una vereda, la Secretaría de Salud coordina con la empresa de servicios públicos y la alcaldía para garantizar condiciones mínimas de saneamiento, mientras el equipo desarrolla acciones educativas sobre el tratamiento casero del agua con las familias afectadas.

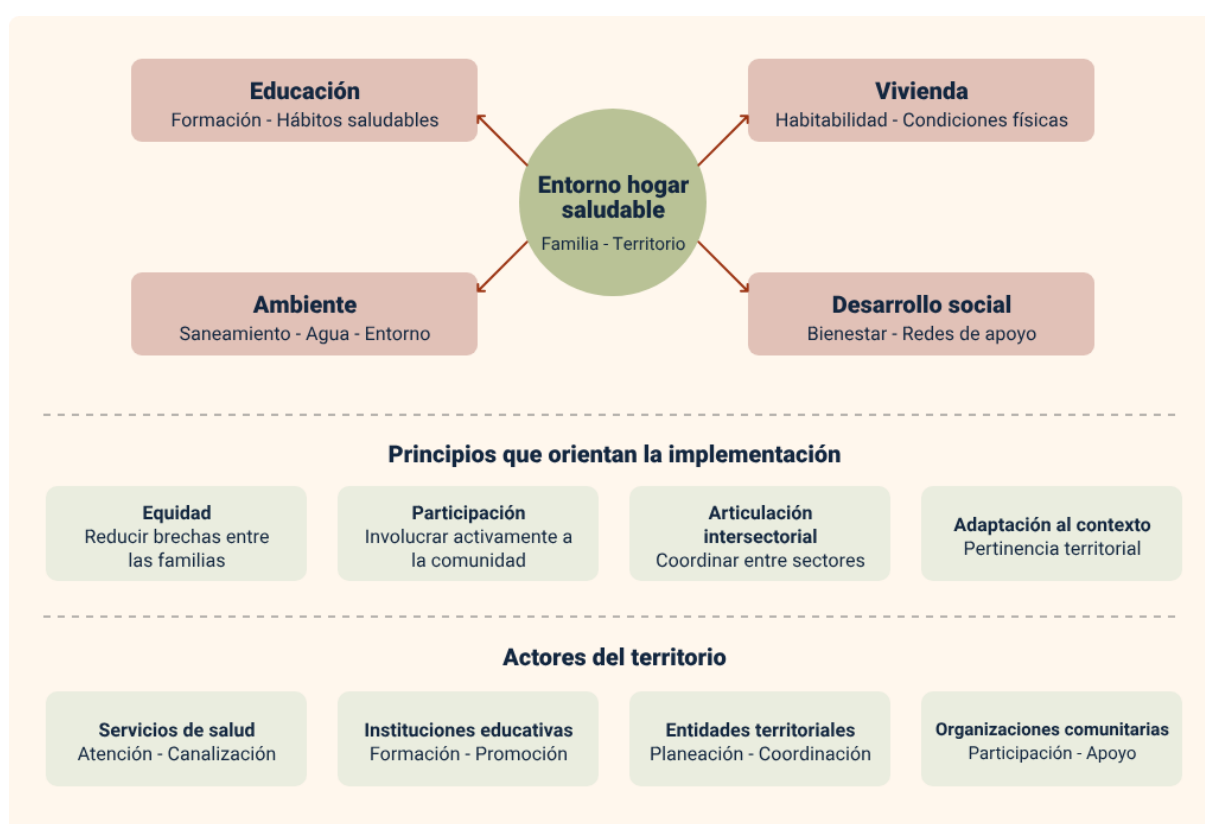
- **Problemáticas de desarrollo social**

Cuando se identifican familias en situación de pobreza extrema, desplazamiento o violencia intrafamiliar, el equipo activa la ruta de articulación con el ICBF, la Unidad para las Víctimas o los programas sociales de la alcaldía, integrando la respuesta en salud con el apoyo institucional que corresponde a cada situación.

Esta integración entre sectores demuestra que las causas estructurales de los problemas de salud en el entorno hogar se abordan de manera más efectiva cuando las instituciones actúan de forma coordinada, evitan duplicar esfuerzos y orientan sus recursos hacia las necesidades reales de cada comunidad colombiana.

Los sectores que inciden en la salud del hogar, los principios que orientan la implementación de la estrategia y los actores del territorio se articulan de manera simultánea en cada comunidad colombiana. La siguiente figura presenta de forma integrada estos tres componentes y muestra cómo convergen en el entorno hogar saludable:

Figura 2. Sectores que inciden en la salud del hogar



La figura evidencia que el enfoque territorial e intersectorial no opera de manera fragmentada; cada sector, cada principio y cada actor se relaciona con el entorno hogar saludable como punto de convergencia. Esta articulación es la que hace posible

intervenir las causas reales de los problemas de salud de las familias y generar respuestas sostenibles en el territorio.

A partir de este enfoque, la estrategia de entorno hogar saludable se orienta hacia la implementación de acciones integrales que reconocen la complejidad del contexto territorial y la necesidad de trabajar de manera articulada con diferentes actores. Este proceso da lugar al análisis de los principios, actores y mecanismos de articulación que hacen posible la implementación de la estrategia en el territorio.

3.1. Principios

El enfoque territorial e intersectorial se fundamenta en un conjunto de principios que orientan la formulación e implementación de acciones en salud pública, garantizando que las intervenciones en el entorno hogar respondan a las condiciones reales de la población y a las dinámicas del territorio. Estos principios permiten estructurar procesos coherentes, integrales y sostenibles, en los cuales se reconoce la interacción entre los diferentes factores que influyen en la salud.

Desde esta perspectiva, los principios orientan la toma de decisiones en el territorio, favoreciendo la implementación de acciones que promuevan la equidad, la participación y la articulación entre actores. En este sentido, los principios del enfoque territorial e intersectorial no solo orientan la planificación de las intervenciones, sino que también facilitan la articulación entre sectores y la adaptación de las acciones a los contextos específicos en los que se desarrollan.

En el siguiente esquema se presentan los principios que orientan la implementación de la estrategia en el entorno hogar:

- Equidad.
- Integridad.
- Participación social.
- Intersectorialidad.
- Pertinencia territorial.
- Continuidad.

La articulación de estos principios permite orientar la implementación de la estrategia de entorno hogar saludable desde una perspectiva integral, en la cual se reconoce la diversidad del territorio y la necesidad de trabajar de manera coordinada entre diferentes actores.

Cada principio se traduce en decisiones concretas durante el trabajo con las familias y comunidades colombianas.

Los siguientes ejemplos ilustran cómo opera cada uno en situaciones reales del territorio:

- **Equidad:** en un municipio del Tolima con zonas rurales dispersas y zonas urbanas, el equipo de salud destina mayor frecuencia de visitas a las veredas con menor acceso a servicios básicos y con familias en condiciones de mayor vulnerabilidad. Esta decisión reconoce que la equidad no consiste en dar lo mismo a todos, sino en orientar los recursos y los esfuerzos hacia quienes más los necesitan para reducir las brechas en salud existentes en el territorio.
- **Integralidad:** cuando el equipo visita una familia en un barrio popular de Ibagué, la intervención no se limita a atender un problema puntual de salud. Abarca simultáneamente las condiciones físicas de la vivienda, la situación de salud de

cada integrante del hogar, las dinámicas de convivencia familiar y el acceso a los servicios disponibles en el sector, respondiendo a la persona y a su entorno de manera articulada, sin fragmentar la atención en aspectos aislados.

- **Participación social:** en corregimientos del sur del Tolima, las juntas de acción comunal participan activamente en la identificación de las necesidades del sector y en la definición de las prioridades de intervención junto con el equipo de salud. Esta participación garantiza que las acciones respondan a lo que la comunidad reconoce como prioritario, fortalece la apropiación de los compromisos acordados y convierte a las familias en protagonistas reales de las decisiones que afectan su propia salud.
- **Intersectorialidad:** ante un brote de enfermedades digestivas por agua contaminada en una vereda del norte del Tolima, el equipo de salud coordina de manera inmediata con la empresa de acueducto, la alcaldía municipal y la institución educativa local. Cada actor aporta desde su competencia: la empresa interviene la fuente hídrica, la alcaldía gestiona los recursos y el equipo de salud desarrolla acciones educativas con las familias afectadas, logrando una respuesta integral que ninguna entidad podría alcanzar actuando de forma aislada.
- **Pertinencia territorial:** en comunidades campesinas del Tolima, las actividades educativas y las visitas domiciliarias se programan respetando los tiempos de cosecha, los días de mercado y las festividades locales, para garantizar la presencia de las familias. En los barrios urbanos, las mismas actividades se adaptan a los horarios laborales de los padres y cuidadores. Esta adaptación al contexto de cada territorio garantiza que las intervenciones sean viables, pertinentes y respetuosas de la vida cotidiana de las comunidades.

- **Continuidad:** en cada visita domiciliaria, el equipo retoma los compromisos acordados con la familia en el encuentro anterior y verifica los avances logrados en las condiciones del hogar. Si una familia acordó tapar los tanques de agua y llevar a los niños a sus controles de crecimiento, la visita siguiente confirma el cumplimiento y ajusta las acciones necesarias. Este seguimiento sostenido convierte las intervenciones en un proceso continuo que produce cambios reales y duraderos en la salud de las familias colombianas.

La aplicación articulada de estos seis principios en el territorio colombiano convierte cada visita domiciliaria en una intervención coherente, justa y sostenible, que reconoce la diversidad de las familias y responde a las condiciones reales de cada comunidad.

La puesta en práctica de estos principios no depende de un solo sector ni de una sola institución. Su aplicación efectiva en el territorio exige la participación coordinada de actores con funciones complementarias, cuya articulación hace posible que la estrategia llegue hasta cada hogar colombiano con pertinencia y continuidad.

3.2. Actores del territorio

La implementación de la estrategia de entorno hogar saludable se desarrolla mediante la participación articulada de actores que intervienen en la gestión de la salud en el territorio, cada uno con funciones específicas que contribuyen al desarrollo de acciones en el entorno hogar.

En este contexto, la intervención no se limita al sector salud, sino que involucra diferentes sectores e instancias que inciden en las condiciones del entorno, lo que permite abordar las situaciones identificadas desde múltiples dimensiones. Esta participación favorece la coordinación de acciones y el uso eficiente de los recursos disponibles en el territorio.

Los actores participan en distintos niveles, desde la planeación y gestión hasta la ejecución de acciones en el entorno familiar, lo que permite una intervención más organizada y coherente con las dinámicas del contexto. De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS, 2016), esta articulación contribuye al fortalecimiento de la gestión del riesgo y la respuesta frente a las necesidades de la población.

En el siguiente esquema se presentan los actores que intervienen en la implementación de la estrategia:

- Entidades territoriales de salud.
- Instituciones prestadoras de servicios de salud.
- Instituciones educativas.
- Entidades de otros sectores (vivienda, agua, desarrollo social).
- Organizaciones comunitarias.
- Familias cuidadoras.

La interacción entre estos actores permite desarrollar acciones complementarias en el territorio, en las cuales se integran capacidades técnicas, institucionales y comunitarias. Este trabajo conjunto facilita la implementación de intervenciones que responden de manera más efectiva a las condiciones identificadas en el entorno hogar.

En el territorio colombiano, cada actor cumple una función específica que complementa la de los demás. Su articulación se evidencia en situaciones concretas como las siguientes:

- Las entidades territoriales de salud lideran la planeación y coordinan la respuesta institucional frente a las necesidades identificadas en los hogares del municipio.
- Las instituciones prestadoras de servicios de salud garantizan la atención oportuna de las familias canalizadas durante las visitas domiciliarias y dan continuidad a los procesos de seguimiento.
- Las instituciones educativas refuerzan los mensajes de promoción de la salud con los estudiantes y sus familias, ampliando el alcance de las acciones iniciadas en el hogar.
- Las entidades de otros sectores como vivienda, agua y desarrollo social intervienen las condiciones estructurales que el sector salud no puede resolver de manera aislada.
- Las organizaciones comunitarias movilizan a la comunidad, facilitan la convocatoria a las actividades de salud y fortalecen las redes de apoyo entre las familias del territorio.
- Las familias y cuidadores participan activamente en los compromisos acordados durante las visitas y son los principales responsables de sostener los cambios en el entorno hogar.

A partir de esta articulación, se consolidan procesos que favorecen la continuidad de las acciones en el territorio, contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades locales y a la generación de respuestas sostenibles frente a las situaciones que afectan la salud de las familias.

La articulación entre los actores del territorio proporciona la estructura institucional y comunitaria que hace posible la estrategia. Para que esa estructura se traduzca en intervenciones pertinentes, es necesario conocer las condiciones reales de los hogares. Los determinantes sociales de la salud explican por qué algunas familias colombianas están más expuestas a enfermedades y ofrecen la base para priorizar las acciones con criterio técnico.

4. Determinantes sociales en el entorno hogar

El análisis de los determinantes sociales en el entorno hogar permite comprender las condiciones que influyen en la situación de salud de las familias, a partir de la interacción de factores materiales, sociales y comportamentales presentes en su contexto cotidiano. Este análisis constituye un elemento clave para la identificación de necesidades y la orientación de intervenciones en salud.

En este sentido, los determinantes sociales no se limitan a condiciones individuales, sino que incluyen aspectos relacionados con la vivienda, el entorno físico, las dinámicas familiares y las prácticas de vida, los cuales inciden en la exposición a riesgos o en la generación de entornos protectores.

El entorno hogar se configura como un espacio en el que convergen múltiples factores que pueden favorecer o afectar la salud, lo que requiere un abordaje que permita reconocer estas condiciones de manera integral. Este análisis facilita la comprensión de las situaciones que requieren intervención, así como la priorización de acciones en el territorio.

A partir de este enfoque, se abordan los elementos relacionados con la clasificación de los determinantes, las condiciones del entorno hogar y los factores de riesgo y protección que inciden en la salud de las familias.

La identificación de necesidades en el entorno hogar genera beneficios concretos para el trabajo en salud pública. Cada uno de estos beneficios se traduce en decisiones y acciones verificables en el territorio colombiano:

- **Fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia**

Capacidad de sustentar cada intervención en información real del hogar, recolectada durante la caracterización, en lugar de actuar por suposición. Ejemplo: cuando la ficha de visita domiciliaria registra hacinamiento en tres de cada cinco casas de un sector, el equipo prioriza esa problemática con criterio técnico y no por percepción personal.

- **Optimizar el uso de recursos disponibles**

Distribución eficiente del tiempo, el talento humano y los materiales educativos según las necesidades reales de cada familia y sector del territorio. Ejemplo: en una vereda del Tolima donde la mayoría de las familias presenta prácticas inadecuadas de manejo del agua, se concentran las jornadas educativas en ese tema, en lugar de dispersar los recursos en múltiples actividades simultáneas.

- **Mejorar la calidad de las intervenciones en el territorio**

Pertinencia y efectividad de las acciones al responder a condiciones específicas de cada hogar, en lugar de aplicar estrategias generales. Ejemplo: cuando la identificación revela que las familias de un barrio trabajan en horas de la mañana, el equipo ajusta los horarios de visita a las tardes, garantizando el contacto real con los cuidadores del hogar.

- **Promover la equidad en salud**

Orientación de los mayores esfuerzos hacia las familias y comunidades con condiciones de mayor vulnerabilidad en el territorio. Ejemplo: al identificar que las familias del asentamiento informal tienen menor acceso a agua potable que las del

resto del barrio, el equipo aumenta la frecuencia de visitas y gestiona con la alcaldía una respuesta diferenciada para ese sector.

La aplicación sistemática de estos cuatro beneficios convierte la identificación de necesidades en una herramienta de gestión que mejora la calidad, la pertinencia y el impacto de cada intervención realizada con las familias colombianas en el entorno hogar.

Reconocer los beneficios de la identificación de necesidades lleva a una pregunta práctica: ¿cómo se organizan las condiciones que afectan la salud de las familias para analizarlas con orden y criterio técnico? La clasificación de los determinantes sociales responde a esa pregunta, al agrupar los factores del entorno hogar en categorías que facilitan su lectura y orientan las decisiones de intervención.

4.1. Clasificación de determinantes

La clasificación de los determinantes sociales en el entorno hogar permite organizar y analizar los factores que influyen en la situación de salud de las familias, facilitando la identificación de condiciones que requieren intervención. Esta clasificación se orienta a reconocer la diversidad de elementos que interactúan en el entorno cotidiano, los cuales pueden incidir tanto en la generación de riesgos como en la construcción de condiciones favorables para la salud.

En este sentido, los determinantes sociales se agrupan en categorías que permiten comprender de manera estructurada las condiciones del entorno hogar, considerando aspectos relacionados con las condiciones materiales, las dinámicas sociales, los comportamientos y las relaciones que se establecen en el contexto familiar.

De acuerdo con los enfoques de salud pública adoptados por el Ministerio de Salud y Protección Social, esta clasificación facilita el análisis integral del entorno, permitiendo orientar la toma de decisiones en función de las necesidades identificadas en el territorio. A continuación, se presenta la clasificación de los determinantes sociales en el entorno hogar:

Tabla 4. Clasificación de los determinantes sociales en el entorno hogar

Tipo de determinante	Descripción	Ejemplos en el entorno hogar	Implicaciones en salud
Materiales	Condiciones físicas y recursos disponibles en el entorno.	Calidad de la vivienda, acceso a agua potable, saneamiento, hacinamiento.	Influyen en la exposición a riesgos ambientales y enfermedades.
Sociales	Relaciones y dinámicas que se desarrollan en la familia y comunidad.	Redes de apoyo, convivencia, relaciones familiares, apoyo comunitario.	Afectan el bienestar emocional y la cohesión social.
Conductuales	Hábitos y prácticas de vida de las personas.	Alimentación, actividad física, higiene, consumo de sustancias.	Inciden en la aparición de enfermedades y en la adopción de prácticas saludables.
Cohesión social	Nivel de integración y participación en el entorno social.	Participación comunitaria, confianza, apoyo social.	Favorece entornos protectores y fortalece la respuesta comunitaria.

La organización de estos determinantes permite comprender cómo diferentes factores interactúan en el entorno hogar, generando condiciones que pueden favorecer o afectar la salud. Este análisis facilita la identificación de situaciones prioritarias, así como la orientación de intervenciones que respondan a las condiciones específicas de las familias.

En el territorio colombiano, los cuatro tipos de determinantes se combinan y se expresan en situaciones concretas de los hogares. A continuación, se presenta cada uno con su definición esencial:

- **Determinantes materiales:** lo físico del hogar que enferma o protege a la familia.

Ejemplo: una casa sin agua potable aumenta el riesgo de diarrea.

- **Determinantes sociales:** las relaciones entre personas que cuidan o afectan la salud.

Ejemplo: una familia unida responde mejor ante una enfermedad grave.

- **Determinantes conductuales:** los hábitos diarios que ayudan o dañan la salud familiar.

Ejemplo: lavarse las manos antes de comer previene enfermedades infecciosas.

- **Cohesión social:** la unión comunitaria que protege la salud de todos.

Ejemplo: un barrio organizado gestiona más rápido la atención en salud.

Cuando estas cuatro condiciones se combinan de manera desfavorable en un mismo hogar, la vulnerabilidad de la familia aumenta. Reconocerlas de forma integrada

permite orientar acciones precisas sobre el entorno físico, los hábitos de vida y las redes de apoyo comunitario, logrando intervenciones más efectivas y sostenibles para las familias colombianas.

La clasificación de los determinantes proporciona el marco para interpretar la realidad de los hogares. Las condiciones del entorno hogar concretan ese marco en situaciones observables durante la visita domiciliaria, identificando con precisión los factores físicos, relacionales y cotidianos que inciden directamente en la salud de cada familia colombiana.

4.2. Condiciones del entorno hogar

El análisis de las condiciones del entorno hogar permite identificar de manera concreta los factores presentes en la vida cotidiana de las familias que influyen en su situación de salud. A diferencia de la clasificación de los determinantes sociales, este análisis se orienta a reconocer cómo estos factores se manifiestan en el contexto real, facilitando la identificación de situaciones que requieren intervención.

En este sentido, las condiciones del entorno hogar se relacionan con aspectos observables del espacio físico, las dinámicas familiares y el entorno inmediato, los cuales pueden favorecer o limitar el bienestar de sus integrantes. Este análisis permite comprender de manera más precisa las condiciones en las que viven las familias y su relación con la salud.

Desde esta perspectiva, el entorno hogar no se limita a la vivienda, sino que incluye el contexto en el que esta se encuentra, así como las interacciones que se desarrollan en su interior. Esto implica reconocer la relación entre las condiciones físicas

del hogar, las prácticas cotidianas y el entorno social en el que se desenvuelven las familias.

Las principales condiciones que pueden identificarse en el entorno hogar se organizan en cinco categorías, cada una con implicaciones directas en la salud de las familias colombianas:

- **Condiciones de la vivienda:** características físicas del espacio habitado, como la ventilación, la iluminación, el hacinamiento y el estado de la infraestructura, que determinan la exposición de la familia a enfermedades respiratorias, infecciones y accidentes dentro del hogar.
- **Acceso a servicios básicos:** disponibilidad de recursos esenciales para la vida diaria, como agua potable, alcantarillado y recolección de residuos, cuya ausencia incrementa de manera directa el riesgo de enfermedades infecciosas en los integrantes del hogar.
- **Entorno inmediato:** características del barrio o comunidad donde se ubica la vivienda, incluyendo la presencia de basuras, la contaminación ambiental y la seguridad del entorno, factores que influyen en la exposición a riesgos ambientales y sociales.
- **Dinámicas familiares:** relaciones y formas de convivencia entre los integrantes del hogar, expresadas en la comunicación, la distribución de roles y la resolución de conflictos, que afectan directamente el bienestar emocional y la salud mental de la familia.
- **Prácticas cotidianas:** acciones habituales relacionadas con el cuidado de la salud, como la higiene, la manipulación de alimentos y la actividad física, que inciden en la prevención de enfermedades y en la promoción de hábitos saludables.

El análisis de estas cinco condiciones permite identificar situaciones que representan riesgos para la salud o, por el contrario, elementos que favorecen la construcción de entornos protectores. Este proceso facilita la priorización de acciones y la orientación de intervenciones pertinentes en el territorio.

En el territorio colombiano, las condiciones del entorno hogar pueden combinarse de formas que no siempre son evidentes a primera vista. Los siguientes casos ilustran situaciones concretas que orientan la intervención:

- Un hogar con buena infraestructura física puede presentar riesgos de salud por prácticas inadecuadas en la manipulación de alimentos.
- Las condiciones del entorno físico y los hábitos cotidianos actúan de manera simultánea e independiente sobre la salud familiar.
- El análisis de cada condición por separado permite identificar con precisión el origen del riesgo y orientar la acción específica que corresponde.
- Una intervención efectiva responde a las necesidades reales identificadas en el hogar y no generaliza las acciones para todas las familias del territorio.

A partir de la identificación de estas condiciones, se hace necesario analizar los factores de riesgo y protección presentes en el entorno hogar, los cuales permiten profundizar en la comprensión de las situaciones que afectan la salud de las familias.

4.3. Factores de riesgo y protección

El análisis de los factores de riesgo y protección en el entorno hogar permite identificar las condiciones que pueden afectar o favorecer la salud de las familias, a

partir de la interacción entre elementos del entorno físico, las prácticas cotidianas y las dinámicas sociales. Este análisis orienta la toma de decisiones en salud, facilitando la priorización de acciones en el territorio.

En este contexto, los factores de riesgo se asocian con condiciones o prácticas que incrementan la probabilidad de afectación en la salud, mientras que los factores de protección corresponden a aquellos elementos que contribuyen al bienestar y a la reducción de riesgos. Desde esta perspectiva, el análisis de estos factores no se limita a la identificación de problemáticas, sino que también reconoce los recursos y fortalezas presentes en el entorno hogar, lo que favorece una intervención más integral.

En el entorno hogar conviven simultáneamente condiciones que amenazan la salud y recursos que la protegen. En el siguiente recurso se presenta cada tipo con su definición y un ejemplo del contexto colombiano:

- **Factores de riesgo**

Condiciones o situaciones presentes en el hogar que aumentan la probabilidad de enfermar a sus integrantes, como el hacinamiento, la ventilación inadecuada, las prácticas deficientes de higiene, los conflictos familiares, la dificultad de acceso a servicios de salud y el aislamiento social. Por ejemplo, una familia que vive en una habitación pequeña con varios integrantes y sin ventilación suficiente tiene mayor probabilidad de presentar enfermedades respiratorias recurrentes entre sus miembros.

- **Factores de protección**

Elementos presentes en el hogar que favorecen el bienestar y reducen la exposición a riesgos, como la vivienda adecuada, los espacios ventilados, los hábitos de higiene apropiados, las relaciones familiares saludables, el acceso a los servicios de

salud y las redes de apoyo comunitario. Por ejemplo, una familia con vínculos comunitarios sólidos cuenta con apoyo para gestionar situaciones de enfermedad, lo que reduce su vulnerabilidad y fortalece su capacidad de respuesta ante las dificultades.

La identificación de estos factores permite orientar acciones que no solo reducen los riesgos presentes en el hogar, sino que también fortalecen los recursos protectores con los que ya cuenta la familia, logrando intervenciones más integrales y sostenibles en el territorio colombiano.

En el territorio colombiano, los factores de riesgo y de protección coexisten en un mismo hogar y orientan decisiones de intervención concretas:

- Una familia con limitaciones en la vivienda, pero con redes de apoyo activas, dispone de recursos comunitarios que facilitan la gestión de su situación de salud.
- El fortalecimiento de las redes de apoyo existentes complementa las acciones de mejoramiento del entorno físico, generando una respuesta más integral.
- La intervención más efectiva combina la reducción de los factores de riesgo con el aprovechamiento de los factores de protección ya presentes en el hogar.

Este análisis integrado de riesgos y protecciones proporciona la base técnica para formular intervenciones coherentes con las condiciones reales de cada familia colombiana y con los recursos disponibles en el territorio.

5. Intervenciones en el entorno hogar

La intervención en el entorno hogar corresponde a la fase operativa posterior al análisis de los determinantes sociales y la identificación de condiciones, riesgos y factores protectores. Su propósito es implementar acciones integrales orientadas a mejorar las condiciones de vida, reducir riesgos en salud y fortalecer capacidades familiares y comunitarias, en coherencia con los lineamientos de salud pública en Colombia.

Este proceso debe articular el análisis territorial, la priorización de necesidades y la ejecución de intervenciones con enfoque diferencial, de derechos y curso de vida, en concordancia con la Política de Atención Integral en Salud (PAIS) y el Modelo de Acción Integral Territorial (MAITE).

El siguiente recurso gráfico permite organizar las necesidades identificadas en el entorno hogar, facilitando su priorización y posterior intervención:

Las necesidades identificadas en el entorno hogar se organizan en cuatro categorías que permiten analizar de manera estructurada las situaciones que requieren intervención. Esta clasificación facilita la priorización de acciones y garantiza que la respuesta del equipo de salud responda a las condiciones reales de cada familia colombiana:

- **Necesidades relacionadas con condiciones del entorno hogar**

Situaciones que afectan la salud de la familia por las características físicas y ambientales del espacio donde vive.

- Deficiencias en la calidad de la vivienda.
- Limitaciones en el acceso a servicios básicos.

- Condiciones ambientales que afectan la salud.

- **Necesidades relacionadas con la salud y el riesgo**

Condiciones de salud existentes o situaciones que aumentan la probabilidad de enfermar en el entorno familiar.

- Presencia de enfermedades o factores de riesgo.
- Problemas asociados a estilos de vida como alimentación y actividad física.
- Riesgos derivados del entorno familiar o social.

- **Necesidades de acceso a servicios**

Dificultades que impiden a la familia utilizar de manera oportuna y adecuada los servicios de salud disponibles.

- Barreras en el acceso a servicios de salud.
- Baja utilización de programas de promoción y prevención.
- Desconocimiento de rutas de atención.

- **Necesidades sociales y familiares**

Situaciones de vulnerabilidad en las relaciones y condiciones sociales que afectan el bienestar de la familia.

- Situaciones de vulnerabilidad social o económica.
- Débil red de apoyo familiar o comunitaria.
- Factores de tensión o conflicto en el entorno familiar.

La clasificación de las necesidades en estas cuatro categorías convierte la información recolectada en el hogar en un insumo técnico organizado y verificable. Esta estructura facilita que el equipo de salud tome decisiones fundamentadas, priorice las

situaciones de mayor impacto y oriente los recursos disponibles hacia las familias colombianas que más lo requieren.

La identificación y clasificación de las necesidades proporciona el diagnóstico que sustenta toda intervención en el entorno hogar. Traducir ese diagnóstico en acciones concretas, viables y sostenibles exige un proceso previo de planeación que reconozca las condiciones reales del territorio, los recursos disponibles y los actores con quienes se articula la respuesta en salud.

5.1. Planeación territorial

La planeación territorial constituye un proceso estratégico previo a la formulación del plan de acción, orientado a garantizar que las intervenciones en el entorno hogar respondan de manera pertinente, viable y sostenible a las condiciones reales del contexto.

Este proceso se fundamenta en el reconocimiento de las características sociales, económicas, culturales e institucionales del territorio, permitiendo ajustar las acciones a las necesidades de la población y a las capacidades existentes. En este sentido, la planeación territorial no se limita a la ejecución de actividades, sino que integra de manera estratégica los recursos, actores y dinámicas territoriales.

Asimismo, orienta la organización de la respuesta en salud, promoviendo la articulación entre los diferentes niveles de atención, los actores institucionales y la comunidad, con el fin de fortalecer la gestión del riesgo en salud y mejorar los resultados en salud pública, en concordancia con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social.

La planeación territorial no es un trámite administrativo, es la decisión estratégica que garantiza que cada visita domiciliaria, cada actividad educativa y cada gestión institucional respondan a las condiciones reales de las familias y del territorio colombiano.

La planeación territorial en la estrategia de entorno hogar saludable debe considerar los siguientes elementos:

- **Contexto territorial:** análisis de las condiciones sociales, económicas y culturales que inciden en la salud de la población.
- **Actores del territorio:** identificación de instituciones, organizaciones comunitarias y redes de apoyo.
- **Recursos disponibles:** reconocimiento de capacidades institucionales, talento humano y recursos materiales.
- **Articulación intersectorial:** coordinación de acciones entre diferentes sectores para abordar los determinantes sociales de la salud.

Estos elementos garantizan que las intervenciones no se desarrollen de manera aislada, sino que respondan a una lógica territorial integral.

Cada elemento de la planeación territorial aporta una función específica dentro del proceso de intervención en el entorno hogar. Reconocerlos con claridad permite tomar decisiones más precisas y coherentes con las condiciones reales de cada comunidad colombiana:

- **Contexto territorial:** análisis de las condiciones sociales, económicas y culturales del territorio que determinan las necesidades de la población y orientan la pertinencia de las intervenciones. Ejemplo: en un municipio del Tolima con alta dispersión rural, el análisis del contexto revela que las familias campesinas tienen menor acceso a servicios de salud, lo que orienta la frecuencia y el tipo de visitas domiciliarias programadas por el equipo.
- **Actores del territorio:** identificación de las instituciones, organizaciones comunitarias y redes de apoyo presentes en el territorio, cuya participación hace posible una respuesta articulada e integral en salud. Ejemplo: en un barrio de invasión de Ibagué, el equipo identifica la junta de acción comunal, el puesto de salud y la institución educativa como aliados clave para coordinar las jornadas de salud y las visitas domiciliarias con las familias del sector.
- **Recursos disponibles:** reconocimiento de las capacidades institucionales, el talento humano y los recursos materiales con los que cuenta el equipo para desarrollar las intervenciones en el territorio. Ejemplo: antes de programar las actividades del trimestre, el equipo verifica el número de profesionales disponibles, los materiales educativos existentes y los medios de transporte accesibles, ajustando el plan a lo que realmente puede ejecutarse en el territorio.
- **Articulación intersectorial:** coordinación de acciones entre diferentes sectores para abordar de manera integral los determinantes sociales de la salud que afectan a las familias. Ejemplo: cuando la caracterización de una vereda evidencia problemas de agua contaminada, el equipo coordina con la alcaldía, la empresa de acueducto y la secretaría de salud para intervenir simultáneamente la causa del problema y educar a las familias sobre el tratamiento casero del agua.

La comprensión integrada de estos cuatro elementos convierte la planeación territorial en una herramienta de gestión que garantiza intervenciones organizadas, viables y coherentes con las dinámicas reales de cada territorio colombiano.

La planeación territorial define el escenario y los recursos con los que se interviene. El paso siguiente consiste en reconocer con precisión qué situaciones de cada hogar requieren atención; la identificación de necesidades convierte la información del territorio en decisiones concretas de intervención.

5.2. Identificación de necesidades

La identificación de necesidades en el entorno hogar corresponde al proceso mediante el cual se reconocen y priorizan las situaciones que requieren intervención, a partir de la información obtenida en la caracterización del territorio y el análisis de las condiciones de salud de las familias.

Este proceso no se limita a la descripción de problemáticas, sino que permite establecer relaciones entre las condiciones del entorno, los factores de riesgo y las capacidades existentes, con el fin de orientar la toma de decisiones en salud. En este sentido, la identificación de necesidades constituye un paso fundamental para la formulación de intervenciones pertinentes y contextualizadas.

Desde esta perspectiva, las necesidades se reconocen a partir de diferentes dimensiones del entorno hogar, las cuales permiten organizar la información de manera estructurada y facilitar su análisis en el territorio.

Cada dimensión agrupa las situaciones más frecuentes que el equipo de salud puede encontrar durante la caracterización de los hogares en el territorio:

Figura 3. Dimensiones para la identificación de necesidades en el entorno hogar



El uso de esta clasificación permite identificar de manera integral las situaciones que afectan la salud de las familias, considerando tanto las condiciones del entorno físico como los aspectos relacionados con la salud, el acceso a servicios y las dinámicas sociales y familiares.

En el proceso de identificación de necesidades, es importante tener en cuenta criterios que orienten su priorización, tales como la magnitud del problema, el nivel de riesgo, la población afectada y la posibilidad de intervención en el territorio. Esto permite enfocar los esfuerzos en aquellas situaciones que requieren una respuesta más inmediata o que generan mayor impacto en la salud.

En el territorio colombiano, la combinación de necesidades identificadas en distintas dimensiones orienta intervenciones específicas y articuladas. Los siguientes ejemplos ilustran cómo se aplica este proceso en situaciones reales:

- **Limitaciones en el acceso a servicios de salud:** cuando una familia no conoce cómo afiliarse al sistema de salud o tiene dificultades para llegar al puesto de salud más cercano, el equipo activa la orientación sobre rutas de atención y gestiona con la entidad territorial la canalización oportuna al servicio que corresponde.
- **Prácticas inadecuadas de cuidado en el hogar:** cuando la caracterización evidencia que una familia no lava los alimentos antes de consumirlos o no realiza el lavado de manos en los momentos clave, el equipo desarrolla una actividad educativa práctica durante la visita, acordando compromisos concretos y verificables con los integrantes del hogar.
- **Combinación de necesidades:** cuando en un mismo hogar coexisten limitaciones de acceso a servicios y prácticas inadecuadas de cuidado, la intervención integra simultáneamente la educación en salud, la canalización hacia los servicios correspondientes y el acompañamiento institucional para garantizar una respuesta completa a las necesidades identificadas.

La articulación entre el diagnóstico de necesidades y las acciones de respuesta demuestra que la intervención en el entorno hogar no improvisa; cada acción educativa, cada canalización y cada gestión institucional responde a una situación concreta identificada en la caracterización del hogar.

A partir de este proceso, se establecen las bases para la definición de intervenciones poblacionales y colectivas, las cuales permiten dar respuesta a las necesidades identificadas en el entorno hogar.

5.3. Intervenciones poblacionales y colectivas

Las intervenciones poblacionales y colectivas representan el nivel de mayor alcance dentro de la estrategia porque actúan sobre condiciones que comparten muchas familias y que ningún hogar puede transformar por sí solo. El trabajo domiciliario y el trabajo comunitario no son opciones separadas, sino componentes que se complementan y se fortalecen mutuamente dentro de una misma respuesta en salud.

En el contexto colombiano, este tipo de intervenciones cobra especial relevancia en territorios donde las condiciones de salud de las familias están determinadas por factores que superan el ámbito doméstico, como la falta de servicios públicos en un asentamiento, la contaminación de una fuente de agua compartida o el limitado acceso a programas de promoción y prevención en zonas rurales dispersas. Actuar de manera colectiva en estos escenarios multiplica el impacto de cada acción realizada con las familias.

Una intervención colectiva bien planeada genera cambios que ningún hogar puede lograr de manera aislada. Cuando la comunidad actúa en conjunto, los resultados en salud son más duraderos y sostenibles para todos sus integrantes.

De esta manera, las intervenciones poblacionales y colectivas complementan las acciones desarrolladas en el entorno hogar, favoreciendo la construcción de entornos saludables y el fortalecimiento de redes de apoyo comunitario.

Estas intervenciones se caracterizan por:

- Estar dirigidas a grupos poblacionales o comunidades.
- Generar impacto en los determinantes sociales de la salud.
- Promover la participación comunitaria.
- Fortalecer redes sociales e institucionales.
- Abordar problemáticas comunes del territorio.

Con el fin de comprender de manera integral el alcance de las intervenciones en el entorno hogar saludable, es necesario diferenciar los niveles de intervención que se desarrollan desde la atención primaria en salud. En este sentido, las acciones pueden orientarse a nivel individual, familiar o colectivo, cada una con propósitos, alcances y estrategias específicas. A continuación, se presenta una tabla comparativa que permite identificar sus características y facilitar la articulación de estas intervenciones en el territorio.

Tabla 5. Comparativa: Intervenciones individuales, familiares y colectivas

Tipo de intervención	Enfoque	Propósito	Ejemplos de acciones	Alcance	Actor principal	Relación con APS
Individual	Centrado en la persona.	Identificar riesgos y promover autocuidado.	Educación personalizada, orientación en salud,	Bajo.	Talento humano en salud.	Prevención individual y control del riesgo.

Tipo de intervención	Enfoque	Propósito	Ejemplos de acciones	Alcance	Actor principal	Relación con APS
			seguimiento a condiciones específicas.			
Familiar (hogar)	Centrado en la familia.	Mejorar condiciones del entorno hogar.	Visitas domiciliarias, orientación familiar, promoción de hábitos saludables.	Medio.	Equipo de salud y familia.	Promoción de la salud en el entorno hogar.
Colectiva / poblacional	Comunitario y territorial.	Impactar determinantes sociales y condiciones colectivas.	Jornadas de salud, campañas educativas, actividades comunitarias, articulación intersectorial.	Alto.	Actores institucionales y comunidad.	Intervención sobre determinantes sociales.

Este enfoque articulado facilita la transición hacia los procesos de seguimiento y evaluación, los cuales permiten medir los resultados de las intervenciones y orientar acciones de mejora continua.

5.4. Procesos de salud pública

Los procesos de salud pública en el entorno hogar corresponden al conjunto de acciones organizadas que permiten gestionar los riesgos en salud, garantizar la atención oportuna y dar continuidad a las intervenciones desarrolladas en el territorio. Estos procesos se articulan con el Sistema General de Seguridad Social en Salud, asegurando la respuesta institucional frente a las necesidades identificadas en las familias.

En este sentido, los procesos de salud pública no se limitan a la prestación de servicios, sino que integran actividades de vigilancia, seguimiento, canalización y gestión del riesgo, orientadas al mejoramiento de las condiciones de salud en el entorno hogar. Su implementación permite fortalecer la capacidad de respuesta del sistema frente a situaciones que requieren intervención.

De acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, estos procesos se desarrollan en coherencia con el Modelo de Acción Integral Territorial (MAITE) y la Resolución 3280 de 2018, lo que garantiza la articulación entre las acciones individuales, colectivas y poblacionales.

Los procesos de salud pública en el entorno hogar se desarrollan en una secuencia de cinco etapas articuladas entre sí. Cada etapa cumple una función específica que garantiza la continuidad y la efectividad de la atención:

- **Identificación del riesgo:** reconocimiento de las condiciones o situaciones que amenazan la salud de la familia en el hogar.
- **Canalización a servicios de salud:** orientación y remisión de la familia hacia el servicio de salud que corresponde según la necesidad identificada.

- **Intervención y atención:** desarrollo de las acciones educativas, preventivas o de atención que responden a la situación identificada en el hogar.
- **Seguimiento del caso:** verificación del cumplimiento de los compromisos acordados y de la evolución de la situación de salud de la familia.
- **Evaluación de resultados:** valoración del impacto de las acciones implementadas para ajustar y mejorar la intervención en el territorio.

La articulación de estas cinco etapas garantiza que la intervención en el entorno hogar no se limite a acciones aisladas, sino que se desarrolle como un proceso continuo, organizado y coherente con las necesidades reales de cada familia y del territorio colombiano.

La secuencia de procesos opera de manera encadenada en el territorio colombiano. Los siguientes ejemplos muestran cómo cada etapa activa la siguiente en una situación real:

- **De la identificación a la canalización:** cuando durante una visita domiciliaria en una vereda del Tolima se detecta a un adulto mayor con signos de hipertensión sin controlar, el equipo activa de inmediato la canalización hacia el puesto de salud más cercano para garantizar su valoración oportuna.
- **De la atención al seguimiento:** una vez la familia recibe la atención en el servicio de salud, el equipo verifica en la siguiente visita que la persona asistió a la cita, que comprende el tratamiento indicado y que las condiciones del hogar no representan un riesgo adicional para su recuperación.
- **Del seguimiento a la evaluación:** cuando el seguimiento de varios casos en un mismo sector revela que las canalizaciones no están siendo efectivas por barreras

de acceso al transporte, el equipo reporta esta situación a la secretaría de salud para ajustar la respuesta institucional y mejorar los resultados en ese territorio.

La aplicación de esta secuencia garantiza que ninguna situación identificada en el hogar quede sin respuesta y que cada acción se conecte con la siguiente de manera organizada, continua y verificable en el territorio.

Los procesos de intervención desarrollados en los temas anteriores culminan en este tema con dos componentes que consolidan la estrategia: la promoción de la salud, que fortalece las capacidades de las familias para cuidarse, y el plan de acción, que organiza en un instrumento concreto y verificable todo lo acordado con cada hogar en el territorio.

6. Promoción de la salud y plan de acción

La promoción de la salud en el entorno hogar se orienta al fortalecimiento de capacidades en las familias para el cuidado de su salud, mediante acciones educativas y de acompañamiento que favorecen la adopción de prácticas saludables. Este enfoque permite generar cambios sostenibles en el tiempo, al involucrar activamente a las personas en el mejoramiento de sus condiciones de vida.

La promoción de la salud se articula con el proceso de intervención en el territorio, permitiendo complementar las acciones orientadas a la gestión del riesgo con estrategias que fortalecen el autocuidado y la toma de decisiones informadas.

De acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, la promoción de la salud se desarrolla mediante procesos educativos, participativos y contextualizados, que responden a las características de la población y del entorno en el que se implementan las acciones.

Estos elementos se articulan de manera progresiva en el trabajo con las familias colombianas. Cada uno cumple una función específica dentro del proceso de promoción y prevención en salud:

a) Promoción de la salud

Proceso orientado a fortalecer las capacidades de las personas para cuidar su salud mediante acciones educativas y de acompañamiento que favorecen la adopción de prácticas saludables, la toma de decisiones informadas y la construcción de entornos protectores en el hogar.

Ejemplo: una familia que reconoce los factores de riesgo de su vivienda y actúa sobre ellos protege su bienestar sin esperar a que aparezca la enfermedad.

b) Herramientas de caracterización

Instrumentos estructurados que permiten recolectar información organizada sobre las condiciones de vida de las familias, facilitando la identificación de necesidades, riesgos y factores protectores como insumo para orientar las decisiones de intervención del equipo de salud en el territorio.

Ejemplo: una planilla diligenciada durante la visita domiciliaria registra las condiciones reales del hogar y define qué situaciones requieren atención prioritaria.

c) Estrategias educativas

Conjunto de métodos y recursos pedagógicos seleccionados y adaptados a las características de la población y del territorio, que facilitan el aprendizaje de prácticas saludables y el fortalecimiento de habilidades para el cuidado de la salud en el entorno familiar.

Ejemplo: una demostración práctica sobre el manejo seguro del agua resulta más efectiva que un folleto en comunidades campesinas con acceso limitado a la educación formal.

d) Formulación del plan de acción

Proceso mediante el cual se organizan de manera estructurada las intervenciones en salud, definiendo objetivos claros, actividades concretas, responsables, recursos disponibles y tiempos de ejecución, en coherencia con las necesidades priorizadas en la caracterización del entorno hogar.

Ejemplo: un plan acordado con una familia de Ibagué define fechas concretas para gestionar la vacunación de los niños y mejorar la ventilación de la vivienda.

La articulación de estos cuatro elementos convierte la intervención en el entorno hogar en un proceso integral: la promoción fortalece capacidades, la caracterización aporta información, las estrategias educativas generan aprendizaje y el plan de acción organiza los compromisos para transformar las condiciones de vida de cada familia.

Conocer los lineamientos que sustentan la promoción de la salud permite comprender por qué las acciones en el entorno hogar van más allá de la atención a la enfermedad. El estudio de sus componentes facilita reconocer cómo se fortalecen las capacidades de las familias y se construyen entornos protectores en cada territorio colombiano.

6.1. Promoción de la salud

La promoción de la salud en el entorno hogar se orienta a la generación de prácticas que favorecen el bienestar de las familias, mediante el fortalecimiento de conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con el cuidado de la salud. Este proceso se desarrolla a través de acciones educativas que permiten a las personas reconocer los factores que influyen en su salud y adoptar medidas para su mejoramiento.

En este sentido, la promoción de la salud no se limita a la transmisión de información, sino que implica procesos de acompañamiento y participación que facilitan la apropiación de prácticas saludables en la vida cotidiana. Este enfoque favorece la sostenibilidad de las acciones y su impacto en el entorno familiar.

En el entorno hogar, la promoción de la salud se orienta hacia cinco aspectos de la vida cotidiana de las familias colombianas, cada uno con un papel específico en la construcción de entornos protectores:

- La higiene personal y del espacio habitado.
- La alimentación saludable y el manejo adecuado de los alimentos.
- La prevención de riesgos presentes en la vivienda y el entorno inmediato.
- El fortalecimiento de las relaciones familiares como factor protector.
- El uso adecuado y oportuno de los servicios de salud disponibles en el territorio.

La atención a estos cinco aspectos en cada visita domiciliaria garantiza que la promoción de la salud responda a las condiciones reales de cada hogar y no a un modelo genérico. Cuando la familia reconoce la importancia de cada uno y los incorpora en su vida cotidiana, los cambios se vuelven duraderos y sostenibles en el tiempo.

El siguiente recurso presenta los cinco componentes que integran la promoción de la salud en el entorno hogar y la función específica que cumple cada uno dentro del proceso de intervención con las familias:

- **Educación en salud:** proceso que fortalece los conocimientos de las familias para tomar decisiones saludables.
- **Autocuidado:** capacidad de cada persona para proteger su salud mediante prácticas y hábitos cotidianos.
- **Participación familiar:** involucramiento activo de todos los integrantes del hogar en el cuidado de la salud.

- **Prevención de riesgos:** conjunto de acciones orientadas a evitar la aparición de enfermedades en el hogar.
- **Entornos saludables:** espacios de vida donde las condiciones físicas y sociales favorecen el bienestar familiar.

La implementación de acciones de promoción de la salud en el entorno hogar permite fortalecer las capacidades de las familias para gestionar su bienestar, favoreciendo la adopción de prácticas saludables y la construcción de entornos protectores.

Las acciones de promoción de la salud generan información valiosa sobre las condiciones de cada hogar. Para aprovecharla de manera organizada, se requieren instrumentos que registren, ordenen y faciliten su análisis. Estos instrumentos se organizan en tres funciones clave:

- **Registro de condiciones del hogar**

Proceso de observación y anotación sistemática de las condiciones físicas, sociales y de salud encontradas durante la visita domiciliaria, que permite documentar la situación real de cada familia en el territorio.

- **Organización de la información**

Clasificación ordenada de los datos recolectados según las dimensiones del entorno hogar, que facilita identificar las necesidades más urgentes y priorizar las intervenciones con criterio técnico y pertinencia territorial.

- **Seguimiento de compromisos**

Verificación periódica del cumplimiento de los acuerdos establecidos con la familia durante las visitas anteriores, que permite ajustar las acciones y garantizar la continuidad de la intervención en el hogar.

Contar con información organizada y actualizada de cada hogar convierte la visita domiciliaria en una intervención técnica fundamentada, que orienta las decisiones del equipo de salud y garantiza que ninguna necesidad identificada quede sin respuesta en el territorio colombiano.

Registrar, organizar y hacer seguimiento a la información del hogar requiere instrumentos técnicos diseñados para ese propósito. Las herramientas de caracterización proporcionan esa estructura y permiten recolectar datos de manera sistemática y convertirlos en insumos útiles para la toma de decisiones en salud.

6.2. Herramientas de caracterización

Las herramientas de caracterización en el entorno hogar permiten recolectar información sistemática sobre las condiciones de vida de las familias, facilitando la identificación de necesidades, riesgos y factores protectores. Estas herramientas constituyen un insumo fundamental para la toma de decisiones en salud, al proporcionar datos que orientan la planificación y ejecución de intervenciones en el territorio.

En este sentido, la caracterización no se limita a la recopilación de datos, sino que implica un proceso organizado de análisis que permite comprender las condiciones del entorno hogar desde diferentes dimensiones. Este enfoque facilita la identificación de

situaciones prioritarias y la definición de acciones acordes con las necesidades de la población.

De acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, la caracterización debe realizarse mediante instrumentos estructurados que permitan obtener información confiable, pertinente y actualizada, en coherencia con los procesos de salud pública y la gestión del riesgo en salud.

La caracterización del entorno hogar se estructura en torno a dimensiones específicas que permiten analizar de forma integral las condiciones de vida de las familias.

Cada dimensión aborda un aspecto particular del entorno y orienta la recolección de información pertinente:

- **Vivienda:** dimensión que evalúa las condiciones físicas del espacio habitado, considerando aspectos como infraestructura, ventilación e iluminación. Su análisis permite identificar factores de riesgo ambiental que inciden directamente en la salud de los integrantes del hogar.
- **Servicios básicos:** dimensión orientada a verificar la disponibilidad y calidad de recursos esenciales como el agua potable. Su ausencia o deficiencia constituye un determinante crítico en la aparición de enfermedades de origen hídrico y sanitario.
- **Salud:** dimensión que indaga sobre la presencia de enfermedades actuales en la familia. Esta información orienta la priorización de intervenciones y el acceso oportuno a los servicios de atención en salud disponibles en el territorio.

- **Prácticas de cuidado:** dimensión que examina los hábitos cotidianos relacionados con la higiene y la manipulación de alimentos. La frecuencia y adecuación de estas prácticas incide en la prevención de enfermedades y en el fortalecimiento del autocuidado familiar.
- **Dinámica familiar:** dimensión que valora la calidad de las relaciones entre los integrantes del hogar, incluyendo comunicación, convivencia y apoyo mutuo. Estos aspectos influyen directamente en el bienestar emocional y en la cohesión del núcleo familiar.
- **Acceso a servicios:** dimensión que verifica la afiliación al sistema de salud y la asistencia a controles médicos. Su análisis permite identificar barreras de acceso e implementar acciones de orientación para garantizar la continuidad en la atención.

El uso de este tipo de herramientas permite organizar la información de manera estructurada, facilitando su análisis y la identificación de necesidades en el entorno hogar. Asimismo, contribuye a la toma de decisiones informadas, orientando la formulación de intervenciones pertinentes y contextualizadas.

La aplicación de estas herramientas en el territorio puede evidenciar condiciones inadecuadas en la vivienda y prácticas deficientes de higiene, lo que permite orientar acciones de educación en salud y acompañamiento familiar en función de las necesidades reales de la población.

El reconocimiento de las dimensiones que estructuran la caracterización del hogar sienta las bases para avanzar hacia los recursos que apoyan los procesos educativos con las familias. Estos recursos, denominados herramientas educativas,

orientan la transmisión de información en salud y facilitan la apropiación de prácticas saludables en el contexto doméstico.

6.3. Herramientas educativas

Las herramientas educativas en el entorno hogar corresponden al conjunto de recursos pedagógicos utilizados para facilitar procesos de enseñanza-aprendizaje orientados al fortalecimiento de prácticas saludables en las familias. Estas herramientas permiten traducir la información técnica en contenidos comprensibles, favoreciendo la apropiación de conocimientos y el desarrollo de habilidades para el cuidado de la salud.

La educación en salud en el hogar se desarrolla considerando las particularidades de cada familia y su contexto. Para garantizar su pertinencia, las herramientas educativas deben responder a las siguientes características:

- **Reconocimiento del entorno:** las herramientas educativas se diseñan considerando las condiciones específicas del lugar donde habitan las familias, de manera que los contenidos respondan a las realidades del contexto territorial en el que se desarrollan las intervenciones.
- **Nivel educativo de la población:** los contenidos y recursos educativos se adaptan al grado de comprensión de las personas, garantizando que la información en salud sea accesible, comprensible y aplicable en la vida cotidiana de cada familia.
- **Dinámicas culturales:** las herramientas educativas reconocen las prácticas, valores y costumbres propias de cada comunidad, asegurando que las acciones en salud sean pertinentes y respetuosas de la identidad cultural de las familias en el territorio.

- **Adaptación a las necesidades familiares:** las herramientas se ajustan a las condiciones y requerimientos particulares de cada hogar, evitando enfoques generalizados que no consideren las diferencias entre las familias atendidas en el proceso de intervención.

La consideración de estos aspectos en el diseño y aplicación de las herramientas educativas garantiza que las acciones en salud tengan un impacto real en las familias. Una herramienta pertinente, accesible y culturalmente adaptada fortalece la apropiación de prácticas saludables y contribuye a la construcción de entornos protectores en el hogar.

Las herramientas educativas disponibles para la intervención en el hogar se clasifican según su función, el tipo de interacción que generan y los recursos que utilizan. Conocer cada tipo permite seleccionar la herramienta más adecuada según las características de la familia y las condiciones del territorio:

- **Material educativo impreso:** recursos físicos que presentan información en salud mediante texto e imágenes, diseñados para apoyar los procesos educativos durante las visitas domiciliarias. Su formato facilita la comprensión de contenidos relacionados con higiene, alimentación y prevención de enfermedades. Ejemplos: cartillas de salud, folletos informativos y guías ilustradas.
- **Estrategias didácticas participativas:** actividades que promueven la interacción directa entre el equipo de salud y la familia, favoreciendo el aprendizaje activo mediante la práctica y la reflexión. Fortalecen habilidades para el cuidado de la salud con la participación de todos los integrantes del hogar. Ejemplos: talleres

de higiene, demostraciones de lavado de manos y juegos educativos orientados a niños y cuidadores.

- **Recursos audiovisuales:** materiales que combinan imagen y sonido para facilitar la comprensión de contenidos en salud, especialmente en poblaciones con limitaciones en la lectura o con acceso a dispositivos tecnológicos. Permiten reforzar los mensajes educativos en diferentes contextos de la intervención. Ejemplos: videos educativos sobre alimentación saludable, presentaciones visuales y audios informativos utilizados en visitas grupales o domiciliarias.
- **Acompañamiento educativo:** orientación directa brindada por el equipo de salud en el hogar, con el propósito de fortalecer prácticas saludables en la vida cotidiana de las familias. Implica presencia y seguimiento continuo, adaptando los contenidos a las condiciones reales de cada hogar. Ejemplos: visitas domiciliarias con demostración de técnicas de higiene, orientación sobre manejo de alimentos y seguimiento a compromisos acordados con la familia.
- **Herramientas comunitarias:** estrategias que involucran la participación colectiva para fortalecer redes de apoyo y el aprendizaje compartido en torno a la salud. Su enfoque grupal favorece la apropiación de prácticas saludables desde la interacción entre pares y el reconocimiento del entorno social como recurso protector. Ejemplos: charlas comunitarias sobre prevención de enfermedades, grupos de apoyo familiar y encuentros barriales orientados a la promoción de la salud.

El uso de herramientas educativas permite adaptar los contenidos en salud a las condiciones del entorno hogar, facilitando la comprensión de temas relacionados con la

higiene, la alimentación, la prevención de riesgos y el uso adecuado de los servicios de salud. Este proceso favorece la apropiación del conocimiento y su aplicación en la vida cotidiana.

La enseñanza de hábitos de higiene mediante una demostración directa durante una visita domiciliaria puede resultar más efectiva que la entrega de información escrita, especialmente en poblaciones con limitaciones en el acceso a la educación formal.

La combinación de diferentes herramientas educativas fortalece el impacto de las intervenciones en el hogar, al integrar estrategias que responden a las características de la población. Para garantizar su efectividad, la selección debe considerar los siguientes criterios:

- **Estrategias visuales:** facilitan la comprensión de contenidos en salud mediante imágenes, esquemas y materiales gráficos adaptados al nivel educativo de la población.
- **Estrategias prácticas:** favorecen el aprendizaje a través de la demostración y la aplicación directa de hábitos saludables en el entorno familiar.
- **Estrategias participativas:** promueven la interacción activa entre el equipo de salud y la familia, fortaleciendo la apropiación de conocimientos mediante el diálogo y la reflexión conjunta.

La selección de estas estrategias debe realizarse en función de las necesidades identificadas en cada hogar, garantizando coherencia entre el contenido educativo, la población objetivo y los propósitos de la intervención.

El reconocimiento de las herramientas educativas y su adecuada selección según las condiciones de cada hogar constituyen la base para avanzar hacia la estructuración de las acciones de intervención. Este proceso se concreta en la formulación de un plan de acción que organiza, prioriza y orienta las actividades a desarrollar con las familias en el territorio.

6.4. Formulación del plan de acción

La formulación del plan de acción en el entorno hogar corresponde al proceso mediante el cual se estructuran de manera organizada las intervenciones en salud, a partir de las necesidades identificadas en el territorio y el análisis de las condiciones del entorno. Este proceso permite definir de forma clara las acciones a desarrollar, orientadas al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias.

En este sentido, la formulación del plan no se limita a la definición de actividades, sino que implica la articulación de objetivos, estrategias y recursos, en coherencia con los procesos de la salud pública y los lineamientos de la Atención Primaria en Salud.

Esto garantiza que las acciones propuestas respondan a las prioridades identificadas y tengan viabilidad en su implementación.

La construcción del plan de acción se fundamenta en tres insumos esenciales que orientan las intervenciones hacia las problemáticas más relevantes del hogar:

- **Caracterización del entorno:** información recolectada sobre las condiciones físicas, sociales y familiares del hogar mediante los instrumentos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, que permite identificar factores de riesgo y necesidades presentes en el territorio colombiano.

- **Análisis de los determinantes sociales:** proceso de interpretación de los factores materiales, conductuales y relacionales que inciden en la salud de las familias, en coherencia con los lineamientos del Plan Decenal de Salud Pública y la Política de Atención Integral en Salud (PAIS).
- **Priorización de necesidades:** selección de las situaciones que requieren intervención con mayor urgencia, considerando el nivel de riesgo, la población afectada y los recursos institucionales disponibles en el territorio, en articulación con los procesos de salud pública definidos para cada región.

La integración de estos tres elementos garantiza que el plan de acción responda a las condiciones reales de cada hogar y se articule con los procesos de salud pública del territorio. De esta manera, las intervenciones formuladas no solo atienden las necesidades identificadas, sino que contribuyen al mejoramiento sostenible de las condiciones de vida de las familias colombianas.

Un plan de acción pertinente define actividades acordes con los recursos disponibles, la participación de los actores del territorio y las necesidades reales de cada hogar.

La comprensión de la formulación del plan de acción en el entorno hogar se fortalece a través del siguiente recurso de audio, en el que se desarrollan de manera clara sus elementos fundamentales y la forma en que se formula de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social:

Transcripción del pódcast. El plan de acción: la herramienta que convierte el diagnóstico en cambios reales.

Mujer: ¿Les ha pasado que salen de una reunión donde se dejaron varias tareas pendientes, pero nadie tiene claro cuáles fueron los acuerdos ni quién debe cumplirlos?

Hombre: pasan los días y empiezan las dudas. Nadie recuerda los compromisos, algunas tareas quedan pendientes y al final las cosas siguen igual.

Mujer: algo parecido puede ocurrir durante una visita familiar del equipo de salud cuando los acuerdos no quedan bien definidos.

Hombre: por eso es importante dejar esos acuerdos por escrito en un plan de acción.

Mujer: el plan de acción es un documento donde quedan registrados los acuerdos que se construyen con la familia.

Hombre: su función es ayudar a organizar qué se va a hacer, quién asumirá cada compromiso y cuándo se revisarán los avances.

Mujer: porque una visita puede identificar muchas necesidades, pero si los acuerdos no quedan organizados, es más difícil convertir las buenas intenciones en resultados concretos.

Hombre: por eso el plan se construye después de conocer la realidad de la familia, entender los factores que están afectando su salud y definir cuáles situaciones requieren atención prioritaria.

Mujer: lo primero es tener claro qué se quiere lograr. Es decir, cuál es el cambio que se espera alcanzar junto con la familia.

Hombre: después hay que definir qué acciones se van a realizar para lograrlo.

Algunas veces puede tratarse de una actividad educativa. En otras ocasiones, de una gestión institucional o de acuerdos para mejorar ciertas condiciones dentro del hogar.

Mujer: también es importante establecer quién asumirá cada compromiso. Si es el equipo de salud, la familia o alguna entidad.

Hombre: pero para que esas acciones realmente puedan llevarse a cabo, también hay que reconocer con qué recursos, apoyos o herramientas se cuenta.

Mujer: y finalmente hay que definir cuándo se realizarán las actividades y cuándo se revisarán los resultados.

Hombre: piensen por un momento en una familia con niños que tienen esquemas de vacunación incompletos. El plan podría incluir llevar a los niños al puesto de salud durante la semana, programar una orientación sobre el tema y revisar los avances durante una nueva visita.

Mujer: no se trata de llenar formatos por llenar. El objetivo es que cada acuerdo tenga un propósito claro y pueda cumplirse.

Hombre: por eso es tan importante la participación de la familia. Porque cuando la familia ayuda a construir el plan, entiende mejor los compromisos, participa en las decisiones y tiene más posibilidades de cumplir lo acordado.

Mujer: pero el valor de un plan no está en lo que dice el papel. El reto comienza cuando llega el momento de cumplir lo acordado.

Hombre: ahí es donde se ve si los compromisos realmente avanzaron o si todo quedó en buenas intenciones.

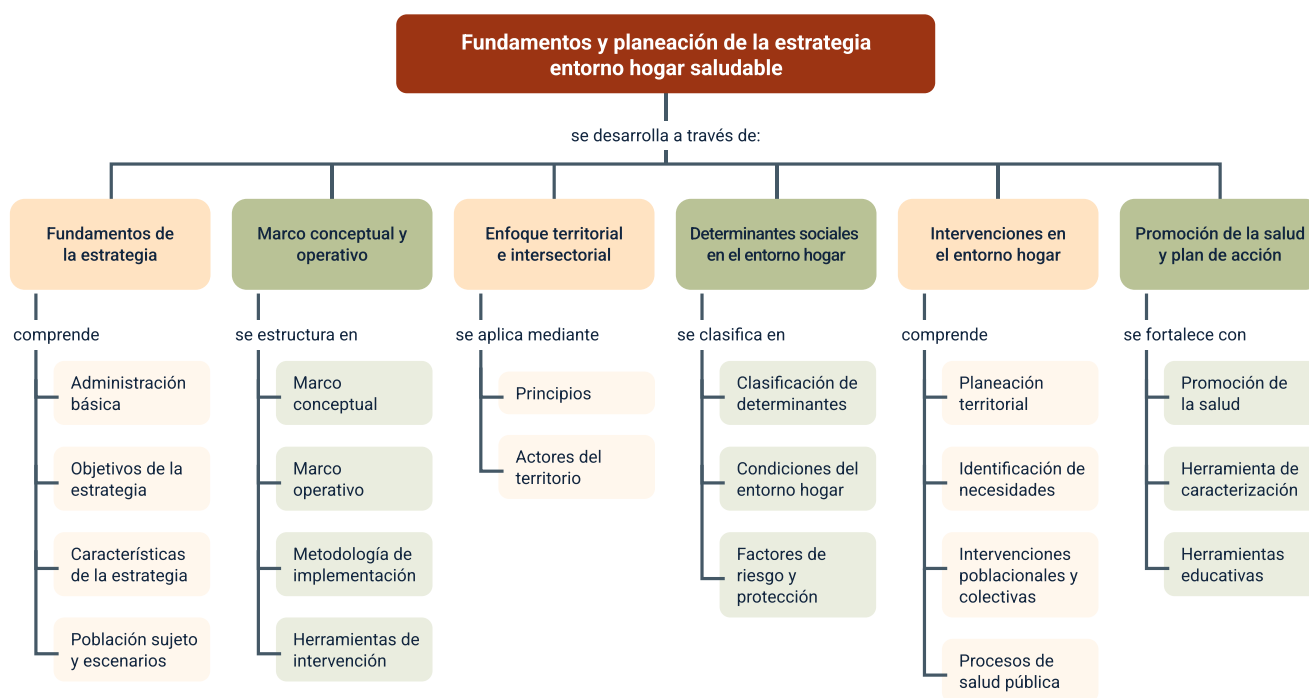
Mujer: porque un plan que nadie vuelve a revisar termina archivado. Pero un plan que se acompaña y se sigue en el tiempo puede transformar la realidad de una familia.

El plan de acción organiza las actividades que se desarrollarán con las familias en el hogar, teniendo en cuenta sus necesidades, las condiciones del territorio y los recursos disponibles para la intervención. Su elaboración parte de la información recolectada durante la caracterización y el análisis del entorno hogar.

Contar con un plan estructurado permite al equipo de salud actuar de manera ordenada, hacer seguimiento a los compromisos acordados con cada familia y ajustar las actividades según los avances y cambios identificados en el hogar. De esta forma, las intervenciones responden de manera oportuna a las situaciones reales de cada familia en el territorio colombiano.

Síntesis

La estrategia de entorno hogar saludable integra saberes conceptuales, operativos y metodológicos que permiten comprender la salud de las familias desde su contexto cotidiano. A lo largo de los contenidos se analizaron los fundamentos de la estrategia, el marco conceptual y operativo, el enfoque territorial e intersectorial, los determinantes sociales, las intervenciones en el entorno hogar y la promoción de la salud como elementos articulados que orientan la planeación de acciones con las familias colombianas. El siguiente mapa conceptual presenta, de manera visual, la organización de los contenidos y la relación entre sus ejes temáticos.



Glosario

Articulación intersectorial: coordinación de acciones entre diferentes sectores e instituciones para intervenir de manera integral los determinantes sociales de la salud.

Atención primaria en salud (APS): enfoque de salud pública orientado a la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la atención integral de las personas, familias y comunidades.

Caracterización: proceso de recolección y análisis de información sobre las condiciones de vida de la población, orientado a identificar necesidades y riesgos en el entorno hogar.

Cohesión social: grado de integración, confianza y apoyo entre los integrantes de una familia o comunidad.

Determinantes sociales de la salud: condiciones sociales, económicas, ambientales y culturales que influyen en el estado de salud de las personas.

Factores de riesgo: condiciones o situaciones que aumentan la probabilidad de que ocurra una enfermedad o un daño en la salud.

Gestión del riesgo en salud: proceso orientado a identificar, analizar y controlar las condiciones que afectan la salud de la población.

Plan de acción: instrumento que organiza las actividades, recursos, responsables y tiempos para la intervención en salud.

Planeación territorial: proceso de organización de acciones en salud que considera las características sociales, económicas y ambientales del territorio.

Población sujeta: grupo de personas o familias hacia quienes se orientan las intervenciones en salud.

Promoción de la salud: proceso que permite a las personas mejorar el control sobre su salud y sus determinantes.

Redes de apoyo: conjunto de relaciones sociales e institucionales que brindan soporte a las personas y familias en el territorio.

Referencias bibliográficas

Ley 1751 de 2015. Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=60733>

Ministerio de Salud y Protección Social. (2012). Lineamientos de la estrategia de entornos saludables. Bogotá, Colombia: MSPS.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2016). Política de Atención Integral en Salud (PAIS). Bogotá, Colombia: MSPS.

<https://www.minsalud.gov.co/Normatividad+Nuevo/Resoluci%C3%B3n%200429%20de%202016.pdf>

Ministerio de Salud y Protección Social. (2018). Modelo de Acción Integral Territorial (MAITE). Bogotá, Colombia: MSPS.

Organización Mundial de la Salud. (2008). Subsanan las desigualdades en una generación: alcanzar la equidad sanitaria actuando sobre los determinantes sociales de la salud. Ginebra: OMS.

Organización Panamericana de la Salud. (2017). Salud en todas las políticas: marco para la acción. Washington, D.C.: OPS.

Organización Panamericana de la Salud. (2012). Entornos saludables: una estrategia para la promoción de la salud. Washington, D.C.: OPS.

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Claudia Johanna Gómez Pérez	Profesional G06. Responsable Ecosistema Virtual de Recursos Educativos Digitales	Centro Agroturístico - Regional Santander
Diana Rocío Possos Beltrán	Responsable de línea de producción	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Laura Brigitte Perea Possos	Experta temática	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Gloria Lida Alzate Suárez	Evaluadora instruccional	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Juan Daniel Polanco Muñoz	Diseñador de contenidos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Veimar Celis Melendez	Desarrollador full stack	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Gilberto Junior Rodríguez Rodríguez	Animador y productor audiovisual	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Jorge Eduardo Rueda Peña	Evaluador de contenidos inclusivos y accesibles	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Jorge Bustos Gómez	Validador y vinculator de recursos educativos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima